

СЕМИНАР «ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ 2.0» ·
МИНТРУД РОССИИ · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25–27 АВГУСТА
2026

Цена заботы

Стоимость социального обслуживания и психиатрической помощи лицам с психическими заболеваниями: сравнение регионов России, развитых и развивающихся стран.

Объёмы помощи, её качество и цена одного дня заботы — в рублях и долларах.

Доклад третий из серии материалов к семинару

48 стран · 19 графиков · более 60 таблиц

Источники: Всемирный банк, ВОЗ (Mental Health Atlas 2011–2024), ОЭСР, SAMHSA, NHS England, национальная статистика, рецензируемые журналы

Подготовлено для участников семинара. Все цифры сопровождаются источниками; расчётные оценки помечены отдельно. Валюта сравнения: российский рубль (для регионов РФ) и доллар США (для мира).

Содержание

Часть I. Как мы считаем: методология **с. 5**

- 1.1. Зачем этот доклад участникам семинара
- 1.2. Три измерения: цена, объём, качество
- 1.3. Валюта сравнения: рубли и доллары, курсы конвертации
- 1.4. Источники данных и их надёжность
- 1.5. Четыре способа измерить «стоимость»
- 1.6. Ограничения и честные оговорки
- 1.7. Словарь терминов
- 1.8. Курсы национальных валют

Часть II. Мировая панорама: миллиард человек и два процента **с. 11**

- 2.1. Бремя: сколько стоит психическое здоровье планеты
- 2.2. Два процента: мировой парадокс финансирования
- 2.3. Кадры: 86 психиатров против одного
- 2.4. Койки: от Японии до Италии — 32-кратный разброс
- 2.5. Разрыв в лечении: кто остаётся без помощи
- 2.6. Экономика возврата: доллар возвращает четыре
- 2.7. Качество: принудительность, длительность, общинность
- 2.8. Четыре мира: таблица групп дохода
- 2.9. Двадцать лет Атласов: динамика мировых медиан

Часть III. Развитые страны: цена высоких стандартов **с. 23**

США · Германия · Великобритания · Франция · Япония · Корея · Италия · Испания ·
Нидерланды · Бельгия · Австрия · Швеция

Часть IV. Развитые страны: продолжение **с. 52**

Норвегия · Финляндия · Дания · Исландия · Ирландия · Греция · Польша · Чехия · Канада ·
Австралия · Новая Зеландия · Израиль

Часть V. Развивающийся мир: помощь по цене чашки кофе **с. 77**

Украина · Беларусь · Казахстан · Грузия · Армения · Китай · Индия · Индонезия · Таиланд ·
Вьетнам · Бразилия · Мексика · Аргентина · Чили · Колумбия · Турция · ЮАР · Нигерия ·
Египет · Кения · Эфиопия · Пакистан · Бангладеш · Уганда и Танзания (справочно)

Часть VI. Россия: федеральная картина **с. 126**

- 6.1. Система в цифрах: 147 больниц и 122,5 тысячи коек
- 6.2. Деньги: сколько стоит психиатрия для бюджета
- 6.3. Цена койко-дня: преискуранты
- 6.4. Суицид: двадцать лет спадания · 6.5. Ранняя помощь и общинные формы · 6.6. Россия на мировой карте

Часть VII. Регионы России: география цены заботы **с. 132**

7.1. Москва: реформа коечного фонда · 7.2. Татарстан · 7.3. Региональные различия смертности · 7.4. ПНИ и соцобслуживание · 7.5. Девять чисел региона

Часть VIII. Цена и качество: итоговое сравнение с. 135

8.1. Сводные таблицы 48 стран · 8.2. Год жизни с тяжёлым расстройством · 8.3. Платить больше — значит ли жить лучше · 8.4. Чек-лист качества · 8.5. Рейтинги · 8.6. Три стратегии

Часть IX. Выводы для семинара и источники с. 142

9.1. Десять главных чисел · 9.2. Что обсудить в секциях · 9.3. Квиз · 9.4. Источники · 9.5. Как работать с докладом · 9.6. Что почитать дальше

Приложения А–В. Полный массив данных 48 стран с. 50

ЧАСТЬ I

Как мы считаем: методология

1.1. Зачем этот доклад участникам семинара

Каждый руководитель социального учреждения рано или поздно отвечает на один и тот же вопрос — из зала, от учредителя, от проверяющих: «Почему день заботы стоит именно столько?». Вопрос звучит просто, но честный ответ требует сравнения: с соседним регионом, с другой страной, с тем, что было десять лет назад. Этот доклад собирает такое сравнение в одном месте — по психиатрической помощи и социальному обслуживанию людей с психическими заболеваниями, самой дорогой и самой чувствительной части нашей системы.

Мы сознательно не ограничиваемся Россией. Цена койко-дня в московской психиатрической больнице становится понятнее, когда рядом лежит цена койко-дня в Токио, Берлине и Найроби. А цифра «2% бюджета здравоохранения» — мировая медиана расходов на психическое здоровье по данным ВОЗ — задаёт честный ориентир для любого бюджетного спора: ниже неё опускается бóльшая часть человечества, выше неё почти не поднимается никто.

Доклад написан для практиков. Поэтому в нём три правила: **только проверенные цифры** с указанием источника; **нет прогнозов без оговорок** — где данные старые, мы говорим, что они старые; **нет «воды»** — каждая страница несёт либо число, либо факт, либо вывод, который можно использовать в работе завтра.

1.2. Три измерения: цена, объём, качество

Сравнивать системы помощи только по деньгам — значит сравнивать рестораны по цене меню, не пробуя еду. Поэтому весь доклад построен на трёх осях, которые повторяются от главы к главе:

Таблица 1.1. Три измерения сравнения и показатели, которыми они измеряются

Измерение	Что показывает	Показатели в этом докладе
Цена	Сколько денег система тратит	расходы на психическое здоровье на душу населения; доля бюджета здравоохранения; цена койко-дня; стоимость года жизни пациента с тяжёлым расстройством
Объём	Сколько помощи физически доступно	койки на 1 000 (на 100 тыс.) жителей; психиатры, психиатрические медсёстры и психологи на 100 тыс.; госпитализации и амбулаторные визиты на 100 тыс.; охват лечением

Качество	Насколько помощь современна и гуманна	доля принудительных госпитализаций; средняя длительность пребывания; доля общинной (внебольничной) помощи; выполнение критериев первичной помощи ВОЗ; смертность от суицидов как интегральный индикатор
-----------------	--	---

Суицидальная смертность используется в докладе как интегральный индикатор качества не потому, что она зависит только от психиатрии — она зависит и от доходов, и от культуры, и от доступности алкоголя, — а потому, что это единственный исход, который страны считают более или менее сопоставимо и публикуют регулярно. Каждый раз, используя его, мы будем напоминать об этой оговорке.

1.3. Валюта сравнения: рубли и доллары, курсы конвертации

По заданию доклада основная валюта сравнения — **российский рубль для регионов России и доллар США для остального мира**. Все российские цифры приводятся в рублях с долларovým эквивалентом; все зарубежные — в долларах с указанием, номинальные они или по паритету покупательной способности (ППС).

Таблица 1.2. Курсы конвертации, принятые в докладе

Период	Курс, Р за \$	Основание
2023 год (среднегодовой)	85,25	Банк России, среднее за год
2024 год (среднегодовой)	92,57	Банк России, среднее за год
2025 год (среднегодовой)	≈83,6	Банк России, среднее за год
Июль–август 2026 (подготовка доклада)	≈79,5	Банк России, текущий курс

Для пересчёта национальных валют третьих стран в доллары используется официальный курс Всемирного банка (индикатор PA.NUS.FCRF) за последний доступный год — он приведён в паспорте каждой страны. Где сравнение по номинальному курсу вводит в заблуждение (дешёвая рабочая сила бедных стран), дополнительно приводятся значения по ППС. Правило простое: **сравниваем цены — используем номинал; сравниваем возможности систем — добавляем ППС**.

Важная оговорка для читателя из соцучреждения: курс 2023 года (85,25 Р/\$) лежит в основе большинства сопоставлений, потому что за 2023-й — самый полный международный массив данных. Каждый рубль в этом докладе можно пересчитать «на сегодня», умножив на отношение курсов.

1.4. Источники данных и их надёжность

Доклад опирается на шесть групп источников. Они перечислены здесь один раз и далее цитируются в тексте по мере использования; полный список — в части IX.

Таблица 1.3. Группы источников

Источник	Что даёт	Надёжность и ограничения
Всемирный банк, Open Data	Расходы на здравоохранение, ВВП, население, смертность от суицидов, врачи и медсёстры, курсы валют — по 48 странам, ряды 2019–2023	Официальная статистика стран, сведённая ВБ; разрывы рядов помечены «н/д»
ВОЗ, Mental Health Atlas 2011, 2014, 2020, 2024	Расходы на психическое здоровье, кадры, койки, госпитализации, охват лечением, структура помощи по группам дохода	Анкетирование министерств здравоохранения; страны отвечают не полностью, данные — нижняя граница реальности
ОЭСР, Health at a Glance / Health Statistics	Психиатрические и общие койки, длительность пребывания по развитым странам	Высокая; охват — только члены и партнёры ОЭСР
Национальные ведомства (SAMHSA — США, NHS England — Великобритания, Assurance Maladie — Франция, Минздрав и Росстат — Россия, Минздрав Индии и др.)	Бюджеты, тарифы, прејскуранты, коечный фонд в национальной детализации	Высокая для своей страны; сопоставимость между странами требует аккуратности
Рецензируемые журналы (The Lancet Psychiatry, EMBO Reports, PLOS, «Сибирский вестник психиатрии и наркологии» и др.)	Глобальные оценки стоимости, стоимость на пациента, окупаемость инвестиций	Высокая; модели авторов оговорены в тексте
Прејскуранты платных услуг российских учреждений	Рыночная цена койко-дня в РФ	Публичные документы учреждений; цены платных услуг не равны себестоимости госзадания, но задают порядок величин

1.5. Четыре способа измерить «стоимость»

В докладе встречаются четыре метрики стоимости — их легко перепутать, поэтому зафиксируем определения:

- **Расходы на душу населения** (\$ на человека в год) — вся сумма, которую система тратит на психическое здоровье, делённая на всё население страны. Удобна для

межстрановых сравнений; мировая медиана по WHO Atlas 2024 — всего \$2,69 на человека в год.

- **Доля бюджета здравоохранения (%)** — какой кусок «медицинского пирога» достаётся психиатрии. Мировая медиана — 2%, не изменилась с 2017 года.
- **Цена койко-дня** (₽ или \$ за день) — стоимость одних суток пребывания одного пациента. Самая «живая» метрика для соцучреждений, но и самая несопоставимая: в неё по-разному включают питание, лекарства, зарплату, амортизацию.
- **Стоимость на пациента в год** — полные годовые затраты системы на одного человека с тяжёлым психическим расстройством. Международное пятистранное исследование 2022 года дало разброс от €311 (Танзания) до €10 493 (Германия) — к этой вилке мы вернёмся не раз.

Запоминаем одно число. Мировая медиана расходов на психическое здоровье — \$2,69 на человека в год (WHO Mental Health Atlas 2024, 75 стран). Это меньше цены чашки кофе. Всё остальное в докладе — развёрнутый ответ на вопрос, кто, как и почему платит больше или меньше этой суммы.

1.6. Ограничения и честные оговорки

Первая. Психиатрическая статистика сопоставима между странами хуже, чем экономическая. Определения коек, кадров и госпитализаций различаются; часть стран включает в психиатрию наркологию, часть — нет. Мы помечаем такие случаи в тексте.

Вторая. Официальная смертность от суицидов систематически занижается там, где существуют культурные или административные барьеры регистрации. Для России разница между данными Росстата (9,1 на 100 тыс. в 2023 году) и оценками ВОЗ (21,4 на 100 тыс. за 2021-й в базе Всемирного банка) показана отдельно — это разные методики, а не «ошибка» в одной из цифр.

Третья. Цены платных услуг — не себестоимость. Они показывают, сколько рынок просит за день заботы, и служат верхней границей; бюджетная себестоимость обычно ниже.

Четвёртая. Где первичных данных нет, доклад использует модельную оценку «2% бюджета здравоохранения» (мировая медиана ВОЗ). Каждая такая оценка заключена в отдельный блок «Модельная оценка» и никогда не смешивается с фактами.

Пятая. Доклад не оценивает клиническую эффективность методик лечения — только ресурсы, объёмы и организацию помощи. Медицинские решения остаются за врачами; наша тема — цена заботы.

1.7. Словарь терминов доклада

Таблица 1.4. Ключевые термины и аббревиатуры

Термин	Значение
Койко-день	Одни сутки пребывания одного пациента в стационаре; базовая единица учёта и тарификации стационарной помощи.
ППС (паритет покупательной способности)	Курс пересчёта валют, выравнивающий покупательную способность: сколько единиц нацвалюты нужно, чтобы купить тот же набор товаров, что за \$1 в США.
ALOS	Average Length of Stay — средняя длительность пребывания в стационаре.
Разрыв в лечении (treatment gap)	Доля людей, нуждающихся в помощи при психическом расстройстве, но её не получающих.
Деинституционализация	Переход от помощи в крупных закрытых учреждениях к помощи в общине: дневные стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание.
Трансинституционализация	Перенос людей с психическими расстройствами из больниц не в общину, а в другие закрытые учреждения (тюрьмы, приюты) — негативный сценарий деинституционализации.
Общинная помощь	Помощь по месту жительства: центры психического здоровья, мобильные бригады, дневные стационары, кризисное жильё.
Сопровождаемое проживание	Форма жизнеустройства, при которой человек живёт в обычном жилье с регулярной поддержкой специалистов.
CAPS	Центры психосоциальной помощи — основа общинной психиатрии Бразилии.
ПНД / ПНИ	Психоневрологический диспансер (амбулаторно-стационарная помощь) / психоневрологический интернат (социальное обслуживание с постоянным проживанием) в системе РФ.
ОМС	Обязательное медицинское страхование; взносы — 5,1% фонда оплаты труда.
mhGAP	Mental Health Gap Action Programme — программа ВОЗ по интеграции базовой психиатрической помощи в первичное звено в странах с ограниченными ресурсами.
Медиана	Значение, делящее ряд пополам; устойчивее среднего к выбросам — поэтому ВОЗ предпочитает медианы в Atlas.
SMI	Severe Mental Illness — тяжёлые психические расстройства (шизофрения, биполярное расстройство и др.).

1.8. Курсы национальных валют

Таблица 1.5. Официальные курсы национальных валют к доллару США (Всемирный банк, PA.NUS.FCRF, последний доступный год)

Страна	Единиц нац. валюты за \$	Год
США	1,00	2023
Норвегия	10,56	2023
Исландия	137,94	2023
Австралия	1,51	2023
Ирландия	0,92	2023
Дания	6,89	2023
Германия	0,92	2023
Нидерланды	0,92	2023
Австрия	0,92	2023
Швеция	10,61	2023
Канада	1,35	2023
Бельгия	0,92	2023
Финляндия	0,92	2023
Великобритания	0,80	2023
Франция	0,92	2023
Новая Зеландия	1,63	2023
Израиль	3,67	2023
Япония	140,49	2023
Италия	0,92	2023
Испания	н/д	—
Республика Корея	1 305,66	2023
Чехия	22,20	2023
Греция	0,92	2023
Чили	840,07	2023
Польша	4,20	2023
Аргентина	296,26	2023
Бразилия	4,99	2023
Россия	85,16	2023
Армения	392,48	2023
Китай	7,08	2023
Мексика	17,76	2023

Колумбия	4 325,95	2023
Беларусь	3,01	2023
Грузия	2,63	2023
Турция	н/д	—
ЮАР	н/д	—
Казахстан	456,17	2023
Украина	36,57	2023
Таиланд	н/д	—
Вьетнам	н/д	—
Египет	30,63	2023
Индонезия	15 236,88	2023
Кения	139,85	2023
Индия	82,60	2023
Нигерия	645,19	2023
Бангладеш	106,31	2023
Эфиопия	54,60	2023
Пакистан	280,36	2023

ЧАСТЬ II

Мировая панорама: миллиард человек и два процента

2.1. Бремя: сколько стоит психическое здоровье планеты

Больше **одного миллиарда человек** на планете живут с психическими расстройствами — это каждый восьмой житель Земли (WHO Mental Health Atlas 2024, опубликован в сентябре 2025 года). Депрессия и тревожные расстройства одни только обходятся мировой экономике в **\$1 триллион в год** потерянной производительности.

Полный ценник психических расстройств для мировой экономики посчитали дважды, и оба раза цифры оказались астрономическими. Оценка Всемирного экономического форума и Гарвардской школы общественного здравоохранения (Bloom et al., 2011): в 2010 году психические расстройства стоили миру **\$2,49 трлн**, из которых прямые затраты на лечение — \$823 млрд, а косвенные потери (невыход на работу, снижение производительности, преждевременная смертность) — \$1 671 млрд. Прогноз тех же авторов на 2030 год — **\$6,05 трлн**: рост почти в 2,4 раза за двадцать лет, быстрее, чем растёт сама мировая экономика.

Мировая стоимость психических расстройств, трлн долл. (ВЭФ / Гарвард, 2011)

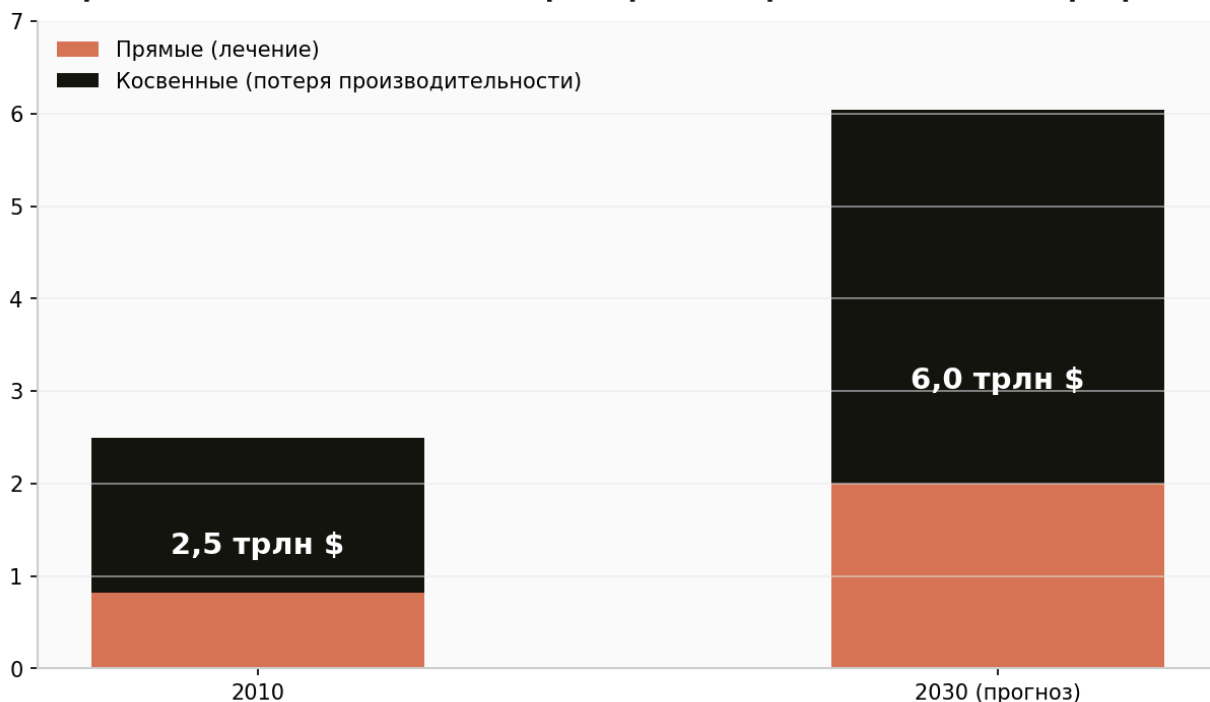


Рисунок 2.1. Глобальная стоимость психических расстройств: 2010 год и прогноз на 2030-й, трлн \$ (Bloom et al., WEF/Harvard, 2011)

Независимая проверка этих чисел (Trautmann, Rehm, Wittchen, EMBO Reports, 2016) подтвердила порядок величин: суммарные глобальные затраты 2010 года — около **\$2,5 трлн**, из них две трети — косвенные. Тот же обзор оценил накопленные потери мировой экономики за 2011–2030 годы в **\$16,3 трлн**, а «стоимость утраченного здоровья» по методологии ценности статистической жизни — ещё в \$8,5 трлн. Для Европейского союза ценник 2010 года составил **€798 млрд** — больше, чем ВВП Нидерландов.

Почему это важно для соцучреждения. Две трети стоимости психических расстройств — не счета за лечение, а потерянная жизнь и труд. Каждый рубль, который система соцобслуживания вкладывает в поддержание самостоятельной жизни подопечного, бьёт именно по этим двум третям — самой большой части мирового счёта.

2.2. Два процента: мировой парадокс финансирования

На фоне триллионных потерь мировые правительства тратят на психическое здоровье в медиане **2% своих бюджетов здравоохранения** — и эта доля не изменилась с 2017 года (WHO Atlas 2024). При этом на психические расстройства приходится заметно бóльшая доля бремени болезней: например, в Англии — более 20% бремени при менее чем 9% расходов NHS.

Абсолютные цифры разделяют мир сильнее любых процентов. В странах с высоким доходом правительственные расходы на психическое здоровье достигают **\$65 на человека в год**; в странах с низким доходом составляют **\$0,04** — четыре цента. Разница — **1 625 раз**. Медиана по 75 странам, предоставившим данные ВОЗ, — \$2,69.

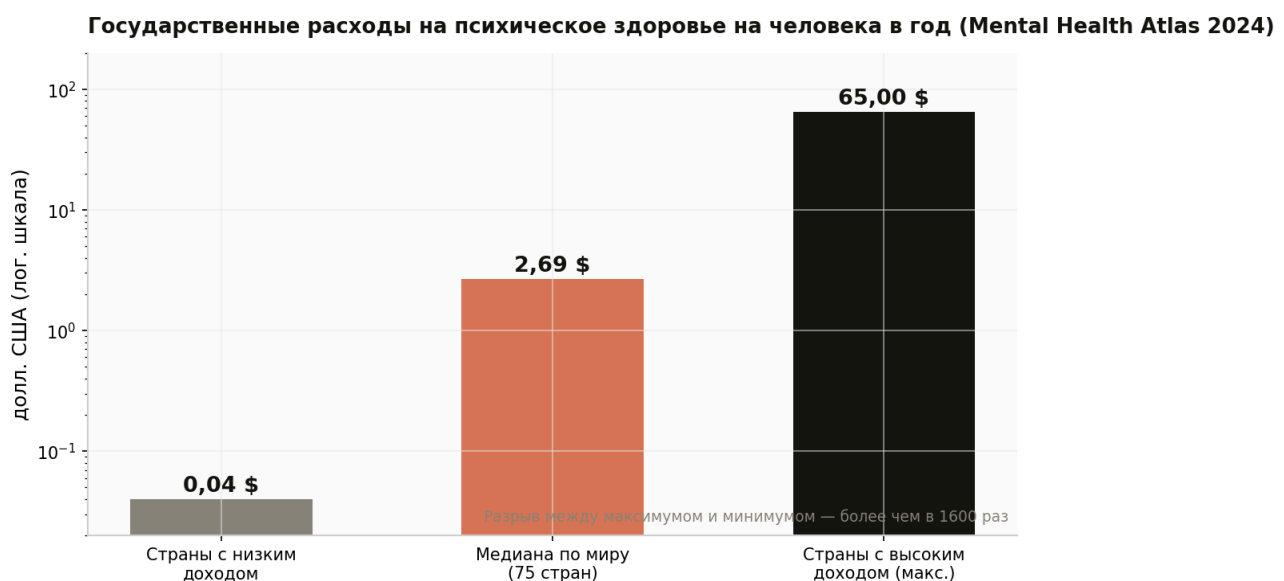


Рисунок 2.2. Государственные расходы на психическое здоровье на человека в год, \$, лог. шкала (WHO Mental Health Atlas 2024)

Динамика медиан говорит о медленном, но реальном росте: по данным последовательных выпусков Atlas, медиана правительственных расходов на психическое здоровье составляла от \$0,20 (страны с низким доходом) до \$4,84 (высокий доход) в 2011 году; в 2014-м правительства в среднем направляли на психиатрию около 3% бюджета здравоохранения (менее 1% — бедные страны, около 5% — богатые); к 2024-му медианная доля стабилизировалась на уровне 2%.

Фоновая база, из которой берутся эти доли, различается на порядки. Расходы на здравоохранение вообще — от \$13 473 на человека в США (16,7% ВВП) до \$30–35 в Эфиопии и Пакистане. Именно поэтому одинаковые «2%» превращаются то в \$270 на человека (США, модельно), то в 60 центов (Пакистан).

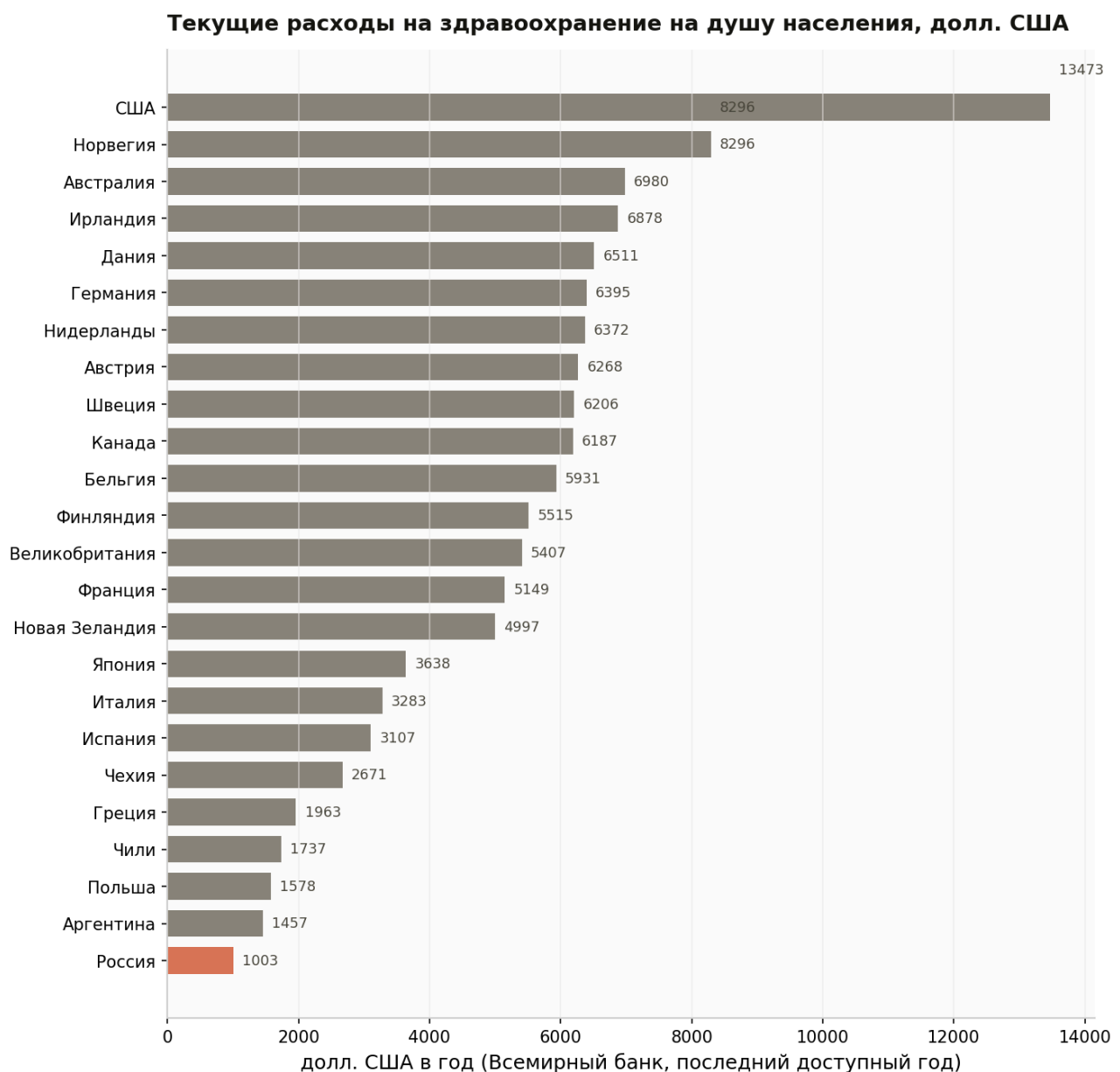


Рисунок 2.3. Расходы на здравоохранение на душу населения в 48 странах, \$ (Всемирный банк, последние данные)

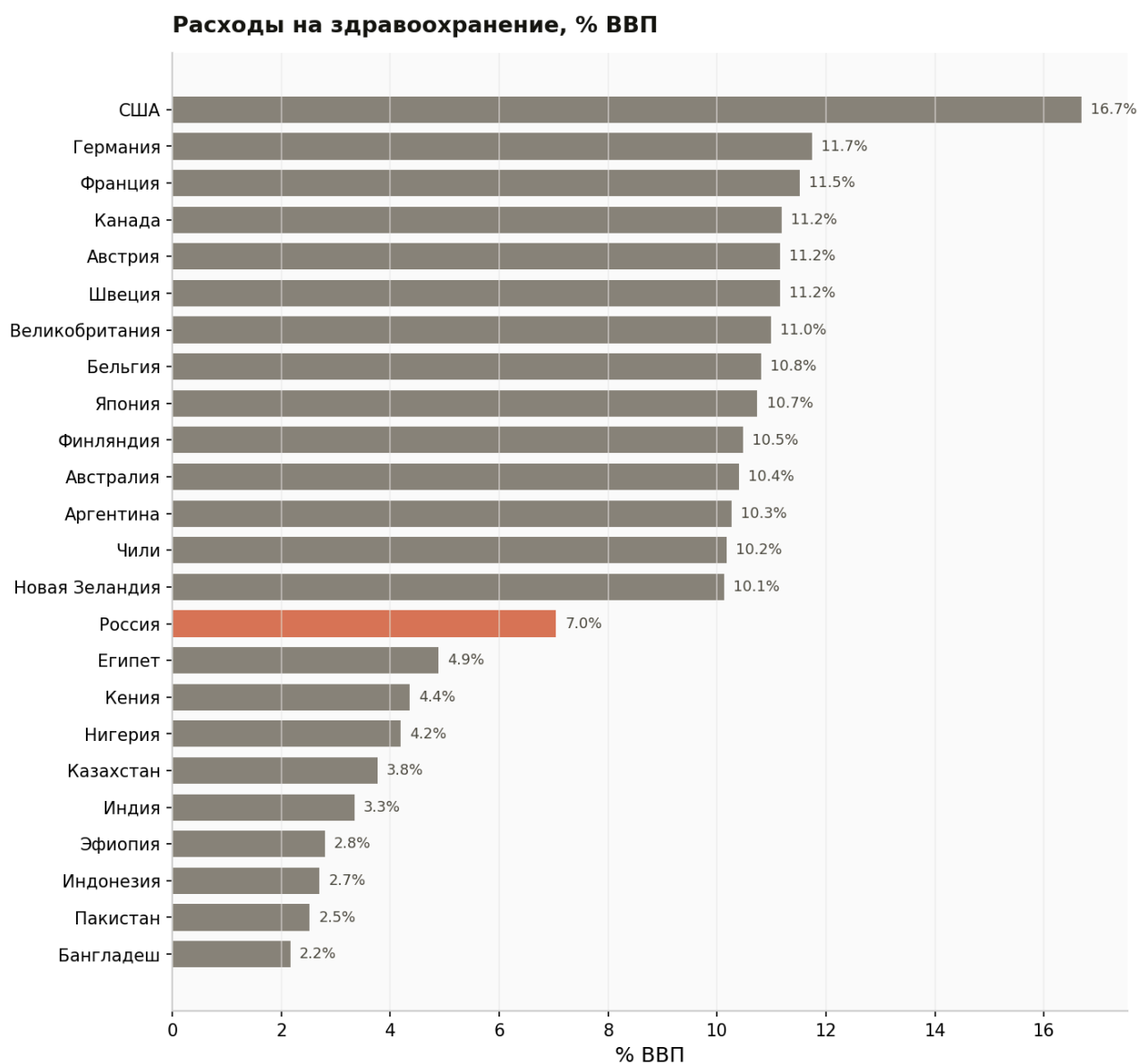


Рисунок 2.4. Расходы на здравоохранение, % ВВП (Всемирный банк)

48 стран: богатство страны и расходы на здравоохранение на человека (последние данные ВБ)

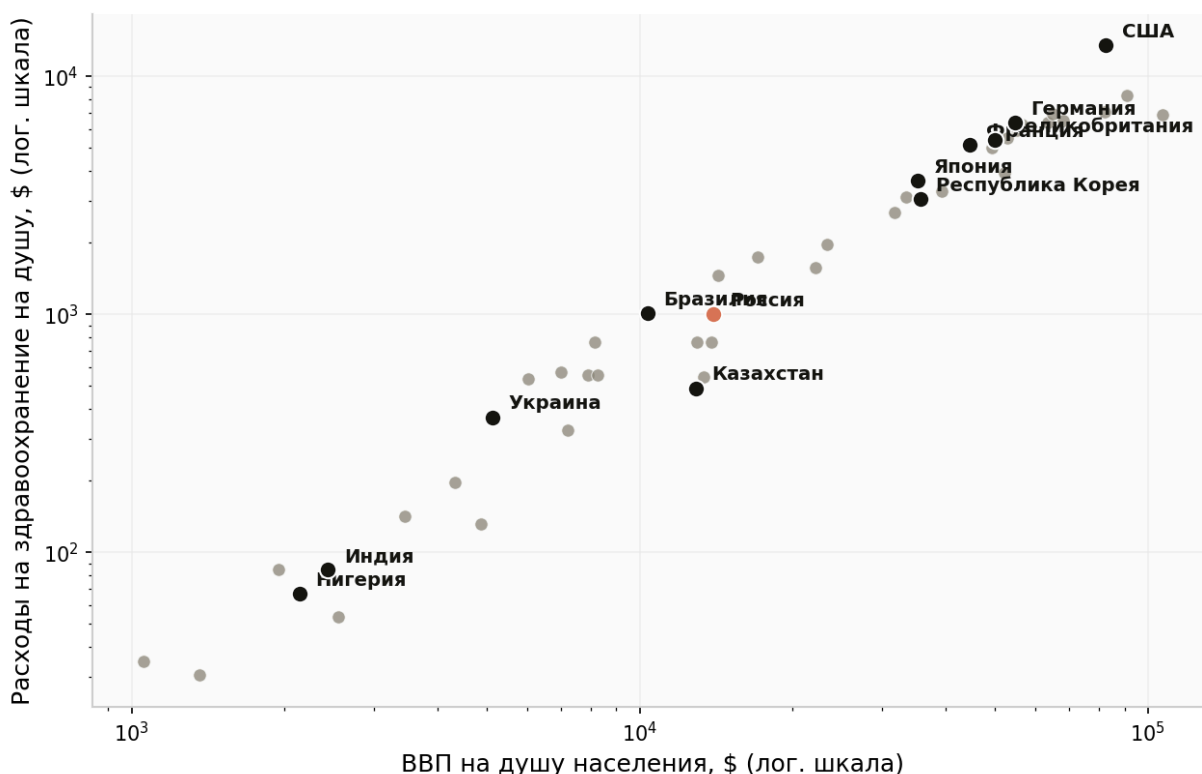


Рисунок 2.5. Богатство страны и расходы на здравоохранение: почти линейная связь на логарифмической шкале

2.3. Кадры: 86 психиатров против одного

Деньги материализуются в людей. По данным ВОЗ за 2021 год (анализ Global Health Observatory, опубликован в 2025-м), медианная обеспеченность психиатрами на 100 тыс. населения составляет: **8,6** в странах с высоким доходом, **1,7** — с доходом выше среднего, **0,4** — с доходом ниже среднего и **0,1** — в беднейших странах. От края до края — **86-кратная разница**. Ещё резче разрыв в психологах (10,7 против 0,1 — более чем в 100 раз) и чуть мягче в психиатрических медсёстрах (29 против 0,4).

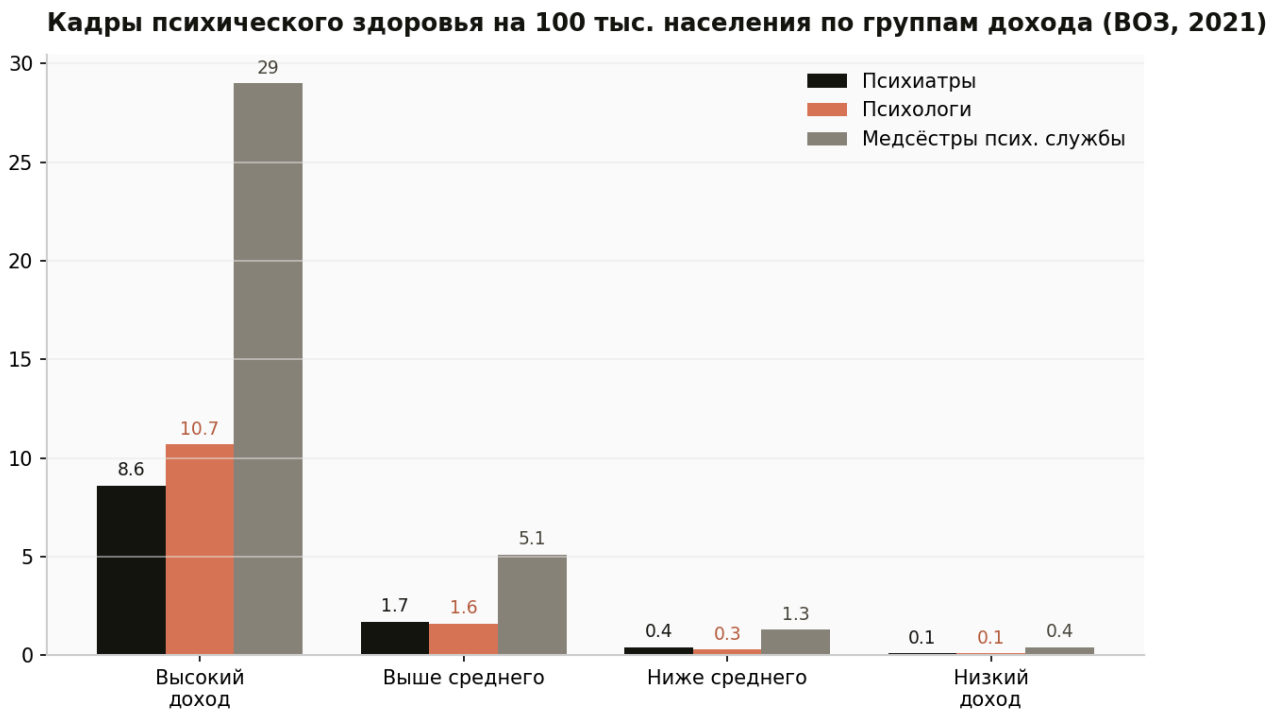


Рисунок 2.6. Кадры психического здоровья на 100 тыс. населения по группам дохода, медианы, 2021 год (WHO GHO)

В абсолютных числах мировая медиана — 13 работников психического здоровья всех профилей на 100 тыс. населения (WHO Atlas 2024). Для сравнения: в России только психиатров — 8,4 на 100 тыс. (2023), то есть страна находится на уровне медианы группы высокого дохода по этому показателю, оставаясь страной с доходом выше среднего. Это наследие советской психиатрической сети — одно из немногих, где Россия «богаче» своего уровня дохода.

2.4. Койки: от Японии до Италии — 32-кратный разброс

Коечный фонд — самый наглядный и самый дорогой ресурс психиатрии. По ОЭСР (2022 год), число психиатрических коек на 1 000 жителей варьирует от **2,58 в Японии** до **0,08 в Италии** — 32-кратный разброс внутри одного клуба развитых стран. Медиана ОЭСР — 0,64; США — 0,35; Россия — около 0,84 (122 537 коек на 146 млн жителей, 2023).

Психиатрические койки на 1 000 населения (ОЭСР, 2022; Росздрав, 2023)

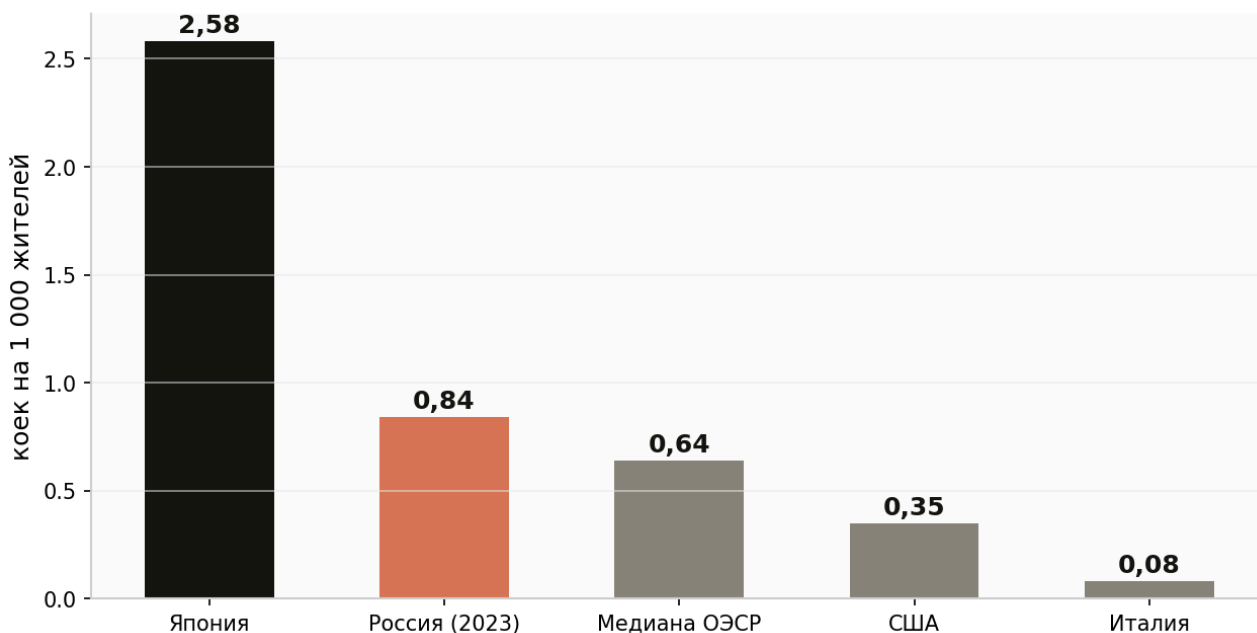


Рисунок 2.7. Психиатрические койки на 1 000 жителей (ОЭСР, 2022; Россия — по национальным данным, 2023)

WHO Atlas 2020 добавляет мировую перспективу: медиана коек в психиатрических больницах — **11 на 100 тыс.** в мире (6,5 в 2014 году), от менее 2 в бедных странах до более 25 в богатых. Медиана госпитализаций — 72 на 100 тыс. в год. Разрыв в амбулаторной помощи ещё драматичнее: медиана обращений — 100 на 100 тыс. в странах с низким доходом против более чем 5 000 в странах с высоким. Общинные дневные учреждения: 0,11 на 100 тыс. (низкий доход) против 5,1 (высокий) — 46-кратная разница, показывающая, что «переход в общину» — пока привилегия богатых систем.

2.5. Разрыв в лечении: кто остаётся без помощи

Даже там, где помощь существует, до неё добираются не все. По WHO Atlas 2024, в странах с низким доходом минимально адекватную помощь получают **менее 10%** нуждающихся; в странах с высоким доходом — **более 50%**. Обнадёживает одно: разрыв сокращается — в более ранних обзорах ВОЗ фиксировала и худшие значения.

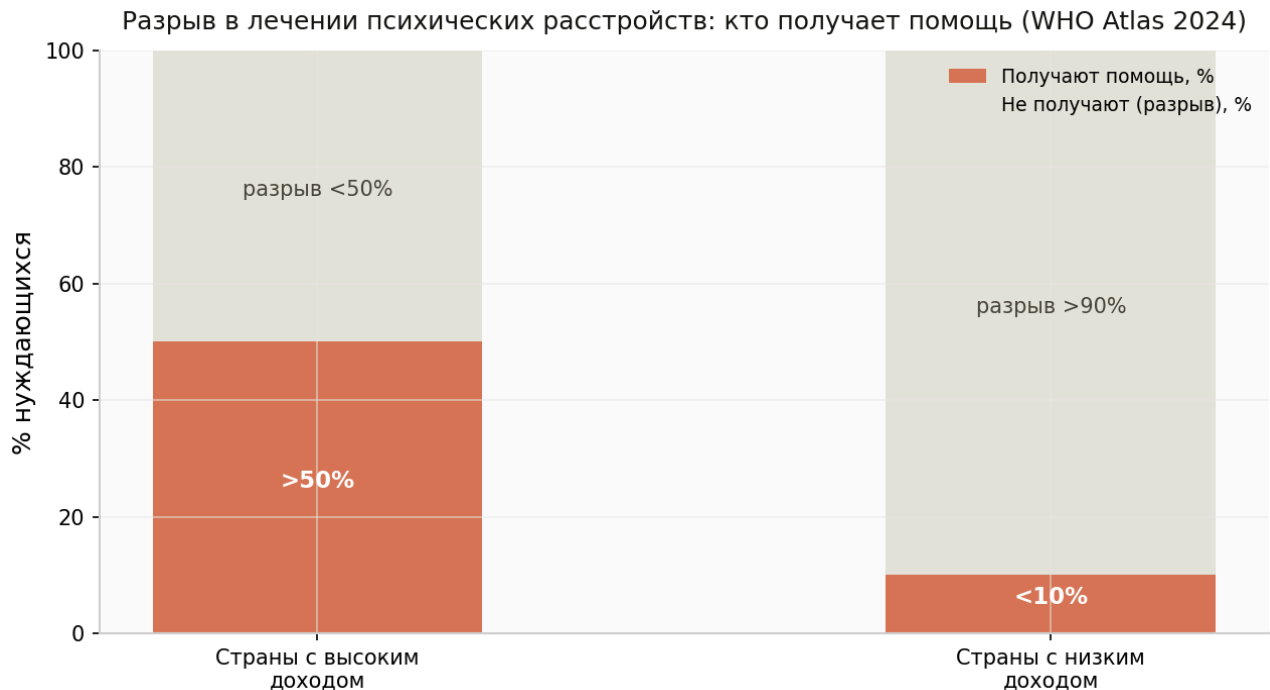


Рисунок 2.8. Разрыв в лечении психических расстройств (WHO Atlas 2024)

По Atlas 2020, охват лечением психозов в медиане составлял 29%, депрессии — 40%. В Индии национальные обследования оценивают разрыв в лечении в 70–92% в зависимости от расстройства — это самые высокие надёжно измеренные значения среди крупных стран. Разрыв — не только проблема бедности: стигма задерживает обращение за помощью и в самых богатых системах, что прямо видно по «белым пятнам» даже скандинавской статистики.

2.6. Экономика возврата: доллар возвращает четыре

Ключевой аргумент для любого бюджетного комитета посчитали Chisholm и соавторы (The Lancet Psychiatry, 2016; исследование при поддержке ВОЗ): масштабирование лечения депрессии и тревожных расстройств в 36 странах с 2016 по 2030 год потребует \$147 млрд, а вернёт \$399 млрд прироста производительности плюс \$310 млрд стоимости дополнительных лет здоровой жизни. Итого **\$709 млрд отдачи на \$147 млрд вложений** — почти 4:1, без учёта немонетизируемого эффекта для семей.

Chisholm et al., The Lancet Psychiatry (2016): каждый вложенный доллар возвращает ~4

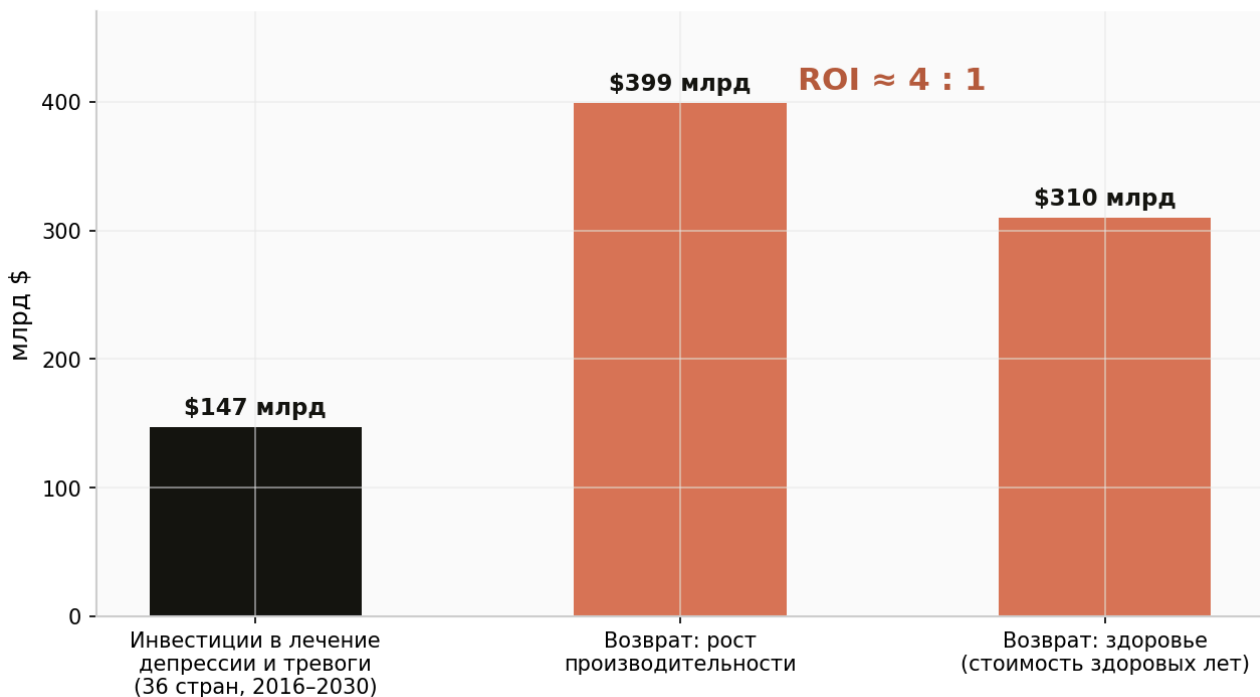


Рисунок 2.9. Инвестиции в лечение депрессии и тревоги и их отдача, млрд \$ (Chisholm et al., 2016)

Как использовать в работе. Соотношение «1:4» — самый цитируемый аргумент ВОЗ в пользу расширения помощи. Он работает и на уровне учреждения: деньги, вложенные в раннюю помощь и сопровождаемое проживание, возвращаются не доходом учреждению, а снижением расходов на кризисную стационарную помощь всей системы.

2.7. Качество: принудительность, длительность, общинность

Три показателя WHO Atlas 2024 задают мировую повестку качества. **Принудительность:** около 50% госпитализаций в психиатрические стационары в мире — недобровольные; в России этот показатель, по национальной статистике, — 5,3% (2023), что в десять раз ниже мировой медианы и требует отдельного разговора о различиях учёта (см. часть VI). **Длительность:** более 20% госпитализаций в мире длятся дольше года — это уже не лечение, а институционализация. **Общинность:** менее 10% стран мира полностью перешли на общинную модель помощи.

При этом первичное звено неожиданно сильно: 71% стран выполняют как минимум три из пяти критериев ВОЗ для интеграции психической помощи в первичное звено (обучение врачей общей практики, доступность базовых препаратов, протоколы направления). Это самый дешёвый из всех возможных шагов — и самый массовый по охвату.

Интегральный индикатор — смертность от суицидов: **727 тысяч смертей в 2021 году** в мире (WHO Atlas 2024). Распределение по группам дохода (2021, WHO GHO): 165 тыс. в странах с высоким доходом, 244 тыс. — с доходом выше среднего, 293 тыс. — ниже среднего, 44 тыс. — в беднейших; низкая доля последних отражает и меньшую смертность, и худшую регистрацию. Карта 48 стран — на рисунке 2.10: от 27,5 на 100 тыс. в Республике Корея до 0,6 в Египте — с уже оговоренной осторожностью в трактовке низких значений.

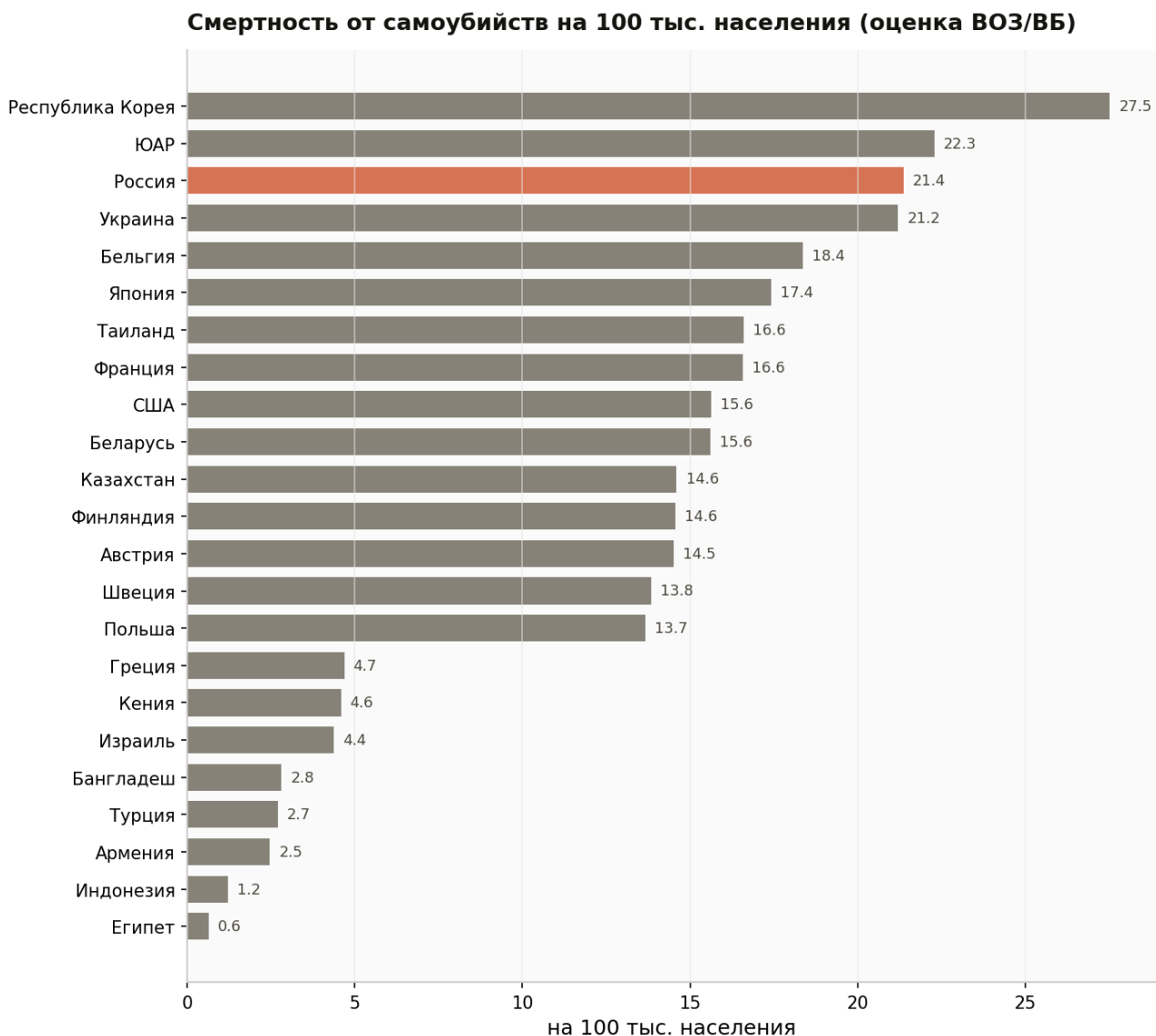


Рисунок 2.10. Смертность от суицидов на 100 тыс. населения в 48 странах (Всемирный банк / ВОЗ, последние данные)

2.8. Четыре мира: сводная таблица групп дохода

Все ключевые медианы ВОЗ по четырём группам стран — в одной таблице. Это «шпаргалка» доклада: по ней удобно определять, к какому из четырёх миров ближе конкретная страна или регион.

Таблица 2.1. Медианные показатели психиатрической помощи по группам дохода (WHO Atlas 2020/2024, WHO GHO 2021)

Показатель (на 100 тыс., если не указано)	Высокий доход	Выше среднего	Ниже среднего	Низкий доход
Психиатры	8,6	1,7	0,4	0,1
Психологи	10,7	1,6	0,3	0,1
Психиатрические медсёстры	29,0	5,1	1,3	0,4
Койки в психиатрических больницах	>25	—	—	<2
Амбулаторные обращения, в год	>5 000	—	—	~100
Общинные дневные учреждения	5,1	—	—	0,11
Госрасходы на псих. здоровье, \$/чел. в год	до 65	—	—	0,04
Получают минимально адекватную помощь, %	>50	—	—	<10
Смерти от суицидов 2021, тыс. чел. (всего)	165	244	293	44

2.9. Двадцать лет Атласов: как менялись мировые медианы

Серия WHO Mental Health Atlas — единственный способ увидеть мировую психиатрию в динамике: одна и та же анкета министерствам здравоохранения повторяется с 2011 года. Сводная динамика ключевых медиан показывает, что мир движется правильно, но медленно.

Таблица 2.2. Мировые медианы психиатрической помощи по выпускам WHO Mental Health Atlas

Показатель	2011	2014	2020	2024
Госрасходы на псих. здоровье, \$/чел. (низкий доход)	0,20	<1% бюджета*	—	0,04
Госрасходы, \$/чел. (высокий доход)	4,84	~5% бюджета*	—	до 65
Доля бюджета здравоохранения (медиана/среднее)	—	~3%	2%	2%
Медиана расходов по ответившим странам, \$/чел.	—	—	—	2,69
Койки в психиатрических больницах, на 100 тыс.	—	6,5	11	—
Госпитализации, на 100 тыс. в год	—	—	72	—
Охват лечением психозов / депрессии, %	—	—	29 / 40	—
Работники псих. здоровья всех профилей, на 100 тыс.	—	—	—	13

* В выпуске 2014 года публиковалась средняя доля бюджета, а не расходы на душу; «—» — показатель в этом выпуске не публиковался. Незаполненность ячеек — само по себе отражение того, как трудно миру собирать эту статистику.

Три вывода из таблицы. **Первый:** доля бюджета застряла — с ~3% (2014, среднее) до 2% (2020–2024, медиана) прогресса нет, и ВОЗ прямо называет это стагнацией. **Второй:** коечный фонд в бедных странах растёт (6,5 → 11 на 100 тыс.) — там ещё достраивают то, от чего богатые страны уже избавляются. **Третий:** разрыв расходов между краями мира не сокращается: от \$0,20/\$4,84 (24 раза) в 2011-м до \$0,04/\$65 (1 625 раз) в 2024-м — богатые системы растут быстрее бедных.

Развитые страны: цена высоких стандартов

Двенадцать стран этой части тратят на здравоохранение от \$3 000 до \$13 500 на человека в год. Это мир, где психиатрическая помощь давно перестала быть только больницей: здесь спорят о долях бюджета, очередях и паритете, а цена года жизни пациента измеряется тысячами евро. Для российского читателя эти профили — «верхние ориентиры»: к ним имеет смысл стремиться по качеству, но не всегда по структуре расходов. Каждый профиль дополнен паспортом показателей Всемирного банка и динамикой 2019–2023 годов.

Таблица 3.1. Развитые страны (первая дюжина): базовые показатели (Всемирный банк)

Страна	Расходы на здравоохран., \$/чел.	% ВВП	Суициды, на 100 тыс.
США	13 473	16,7	15,6
Германия	6 395	11,7	12,9
Великобритания	5 407	11,0	9,6
Франция	5 149	11,5	16,6
Япония	3 638	10,7	17,4
Республика Корея	3 044	8,6	27,5
Италия	3 283	8,4	7,0
Испания	3 107	9,2	8,7
Нидерланды	6 372	9,8	11,5
Бельгия	5 931	10,8	18,4
Австрия	6 268	11,2	14,5
Швеция	6 206	11,2	13,8

3.1. США

США — самая дорогая система психиатрической помощи в мире в абсолютном выражении: **\$238,4 млрд** расходов на лечение психических расстройств в 2020 году (SAMHSA, отчёт SMA-14-4883). Это примерно 6,5% всех американских расходов на здравоохранение.

Динамика показывает устойчивый рост: со \$147 млрд в 2009 году расходы выросли на 53% за одиннадцать лет, обгоняя инфляцию. Полный счёт 2020 года с учётом расстройств, связанных с употреблением веществ, — **\$280,5 млрд**, из которых 85% приходится именно на психические расстройства.

США: расходы на лечение психических расстройств, 2010–2020, млрд \$

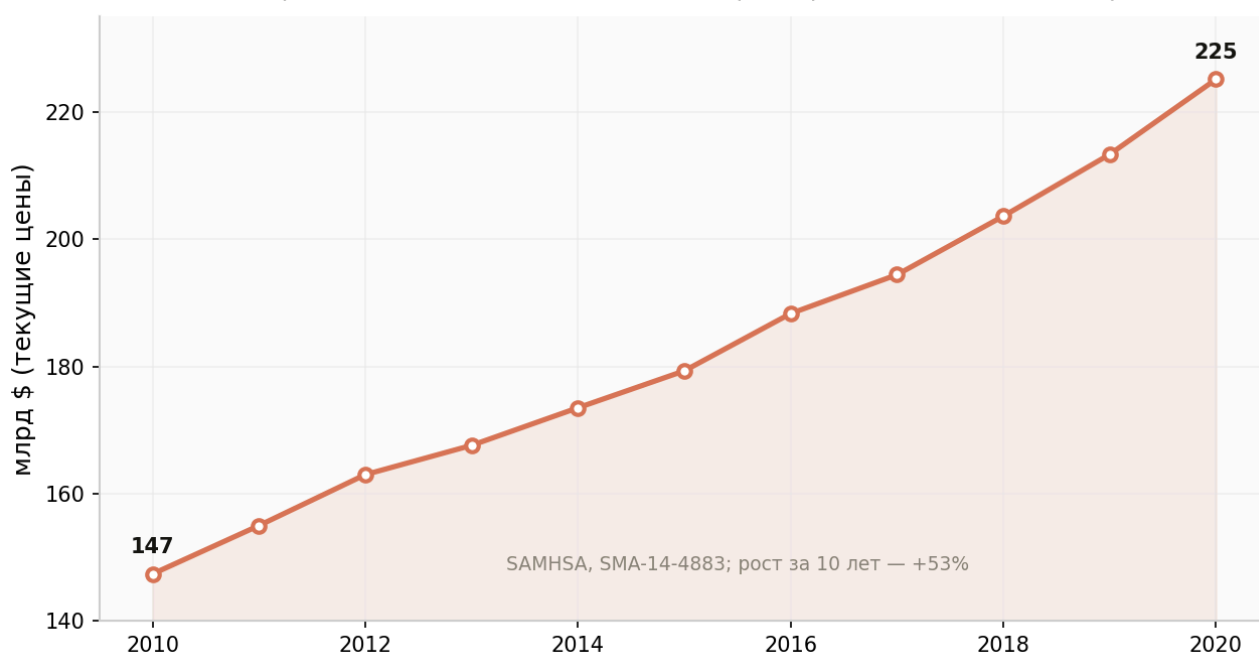


Рисунок 3.1. США: расходы на лечение психических расстройств, 2010–2020 (SAMHSA)

Структура плательщиков — главный урок американской модели для российского читателя: крупнейшим плательщиком психиатрической помощи является государственная программа **Medicaid** (медицинская помощь малоимущим) — около 26–30% всех расходов. То есть даже в самой «рыночной» системе мира психиатрия финансируется преимущественно государством: частное страхование не любит длинные и непредсказуемые психиатрические случаи.

При рекордных расходах на душу (\$13 473 на здравоохранение в целом — первое место в нашей выборке) коечная база США скромна: 0,35 психиатрических коек на 1 000 жителей против медианы ОЭСР 0,64 — наследие деинституционализации 1960–1980-х, когда коечный фонд страны сократился почти в десять раз. Результат — перенос нагрузки на тюрьмы и службы бездомных, что в американской литературе

называется «трансинституционализацией»: дешевле больницы, но не дешевле для бюджета в целом. Смертность от суицидов — 15,6 на 100 тыс. (2021), выше мировой (9,4).

Вывод для семинара: американский кейс показывает, что «много денег» не равно «много стационарной помощи». США платят за амбулаторную и кризисную помощь самую высокую цену в мире, а отсутствие коек компенсируют самым дорогим способом — через экстренные службы и правоохранительную систему.

Таблица 3.2. США: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	13 473,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	16,7	2023
ВВП на душу населения, \$	82 587	2023
ВВП на душу по ППС, \$	82 587	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	15,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,68	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	78,4	2023
Население	336,8 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	1,00	2023

Таблица 3.3. США: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	10 550	65 228	15,1
2020	11 648	64 465	15,0
2021	12 080	71 441	15,6
2022	12 586	78 009	—
2023	13 473	82 587	—

Модельная оценка. Если США направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$269,5 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **15,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.7 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем —

не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,68 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 78,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.2. Германия

Германия — эталон «дорогой, но предсказуемой» помощи: год обслуживания одного пациента с тяжёлым психическим расстройством (шизофрения и родственные) обходится системе в **€10 493** — максимум пятистранного международного исследования 2022 года (Германия, Израиль, Уганда, Индия, Танзания).

Немецкая цифра важна как верхняя точка мировой вилки стоимости года жизни с тяжёлым расстройством: от €311 (Танзания) до €10 493 (Германия) — 33-кратный разброс, который лишь частично объясняется ценами: большая часть разницы — сам объём предоставляемой помощи. Германия тратит на здравоохранение 11,7% ВВП (\$6 395 на человека, 2023) — второе место в выборке после США.

Смертность от суицидов — 12,9 на 100 тыс., выше мировой медианы, но ниже значений стран Восточной Европы. Немецкая модель держится на обязательном страховании (GKV) с жёстким разделением: стационарная психиатрия финансируется больничными кассами по дневным ставкам, а реабилитация и социальное сопровождение — пенсионным страхованием и земельными бюджетами. Именно эта трёхконтурная конструкция делает «полную стоимость пациента» в Германии самой высокой из измеренных: в счёт входит и пенсионное обеспечение, и сопровождаемое проживание.

Вывод для семинара: когда мы сравниваем «стоимость койки» в России и Европе, немецкий пример напоминает: правильно сравнивать не койко-день, а полный годовой контур — лечение, реабилитация, жильё, пенсия. Только так видна настоящая цена заботы.

Таблица 3.4. Германия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 394,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,7	2023
ВВП на душу населения, \$	54 777	2023
ВВП на душу по ППС, \$	72 262	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	12,9	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,53	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	12,2	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,0	2023
Население	83,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.5. Германия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 447	47 656	12,5
2020	5 907	47 395	12,9
2021	6 654	52 349	12,9
2022	6 226	50 507	—
2023	6 395	54 777	—

Модельная оценка. Если Германия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$127,9 на человека в год ≈ 118 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **12,9 на 100 тыс. (2021)**: выше среднемировой (9,4) в 1,4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,53 врача на 1 000 жителей и 12,2 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$72 262: в 1,3 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,0 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.3. Великобритания

Великобритания — единственная крупная страна, где доля психического здоровья в бюджете системы публично контролируется как отдельный KPI. NHS England потратила на психическое здоровье **£12,8 млрд в 2022/23** (8,1% бюджета); доля выросла до 9,0% в 2023/24, затем снизилась до 8,78% (2024/25) и запланирована на уровне 8,68% при абсолютном росте до **£15,7 млрд в 2025/26** (база NHS England £180,8 млрд) и £16,1 млрд в 2026/27 (8,40%). По курсу ~1,24 \$/£ это около \$19,5 млрд в 2025/26 году.

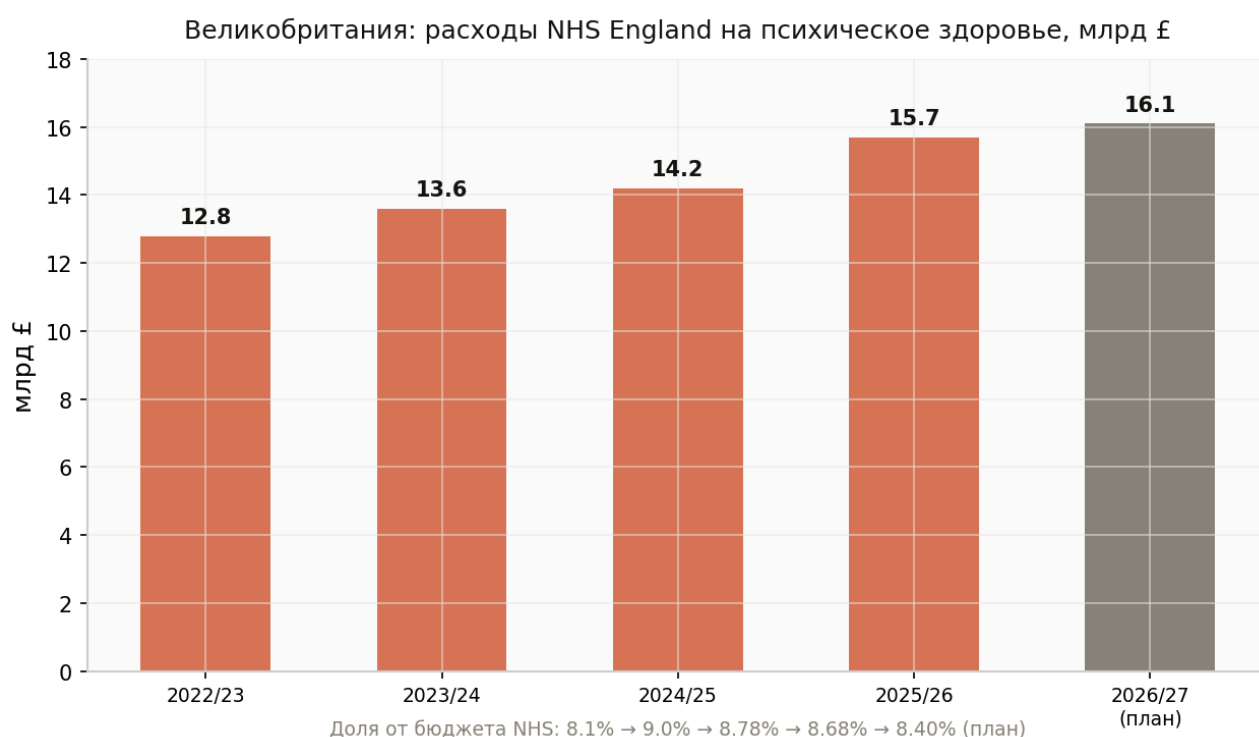


Рисунок 3.2. Великобритания: расходы NHS England на психическое здоровье, млрд £

Более широкий контур интегрированных советов (ICB) — психическое здоровье плюс нарушения обучаемости и деменция — оценивается на 2025/26 год в **£18,0 млрд** (14,2% их бюджетов) плюс £2,6 млрд специализированных услуг: суммарно **£20,6 млрд**. На человека с населением 68,5 млн это около \$370 в год по широкому контуру — в пять раз выше немецкой модели «год пациента», но здесь считается вся система на всё население.

Обратная сторона — масштаб неудовлетворённого спроса: **1,8 млн человек** стоят в очереди на психиатрическую помощь NHS, а полная стоимость психических расстройств для Англии оценивается в **~£300 млрд в год** (лечение, потеря производительности, неформальный уход). Диспропорция «более 20% бремени

болезней — менее 9% расходов» стала главным аргументом британской кампании за паритет психического и соматического здоровья.

Смертность от суицидов — 9,55 на 100 тыс. (2021), почти точно мировая медиана; для богатой страны с бесплатной помощью это напоминание, что доступность сама по себе не обнуляет риск.

Вывод для семинара: британский опыт легализовал язык «паритета» — идею, что психическое здоровье должно получать долю бюджета, соизмеримую с его долей в бремени. Этот же аргумент работает в любом российском региональном бюджетном процессе.

Таблица 3.6. Великобритания: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	5 407,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,0	2023
ВВП на душу населения, \$	49 920	2023
ВВП на душу по ППС, \$	60 787	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	9,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,30	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,2	2023
Население	68,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,80	2023

Таблица 3.7. Великобритания: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	4 260	43 161	9,4
2020	4 866	40 815	8,9
2021	5 645	47 696	9,6
2022	5 112	47 035	—
2023	5 407	49 920	—

Модельная оценка. Если Великобритания направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$108,1 на человека в год** $\approx$ **87 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **9,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.0 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота

регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,30 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$60 787: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.4. Франция

Франция — рекордсмен по доле психического здоровья в расходах среди крупных стран: **около 14%** расходов на здравоохранение, или **€23,3 млрд** в 2020 году — в среднем **€2 800 на одного пациента**, состоящего на учёте. По более свежей методике учёта долговременных состояний (ALD), психические расстройства обошлись Assurance Maladie в **€27,8 млрд в 2023 году** — 13,7% всех её расходов.

Уникальные французские данные — распределение счёта между плательщиками. Стоимость психического здоровья только трудоспособного населения в 2022 году — **€24,7 млрд**, из которых государственное страхование оплатило €14,8 млрд, работодатели — €7,6 млрд (нетрудоспособность, замещение, производственные потери), дополнительное страхование — €2,3 млрд. Почти треть счёта ложится на работодателей — факт, который французы используют для вовлечения бизнеса в профилактику выгорания.

Франция: стоимость психического здоровья трудоспособного населения, 2022 — €24.7 млрд

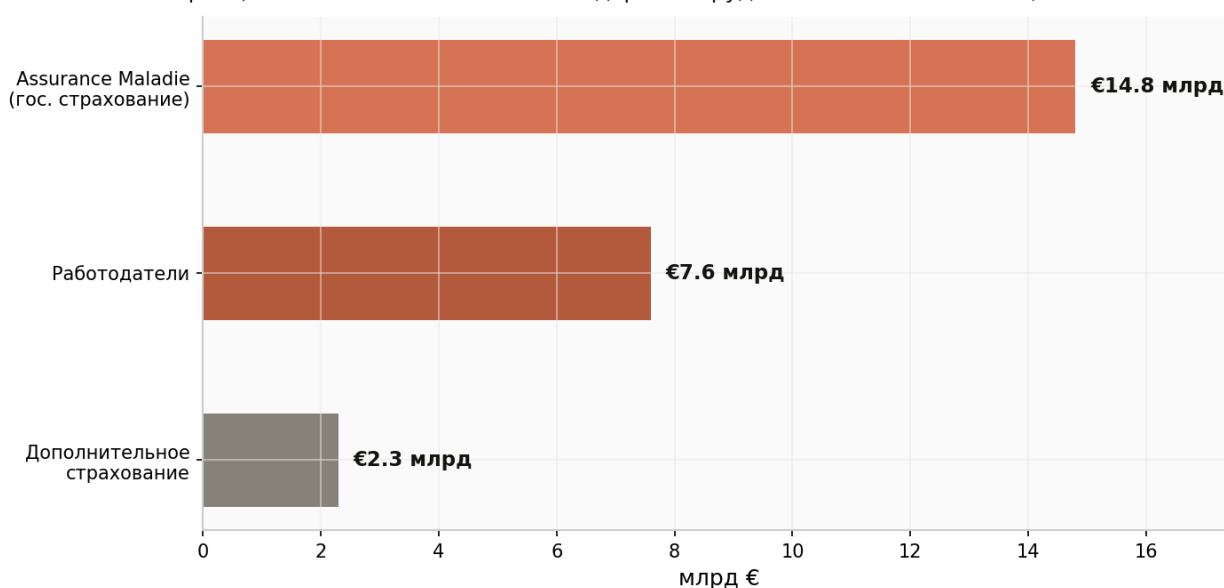


Рисунок 3.3. Франция: структура стоимости психического здоровья трудоспособного населения, 2022

Темная сторона французской щедрости — смертность от суицидов **16,6 на 100 тыс.**, одно из высших значений в Западной Европе и выше, чем в России по данным Росстата. Дорогая помощь не гарантирует низкий суицид — культурные и алкогольные факторы работают независимо от бюджета.

Вывод для семинара: французская практика показывает, как считать полную стоимость вопроса для всех участников — государства, работодателей,

страховщиков. Такой же трёхсторонний счёт можно построить и для российского региона: ОМС, бюджет соцзащиты, работодатели подопечных и их семьи.

Таблица 3.8. Франция: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	5 149,1	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,5	2023
ВВП на душу населения, \$	44 700	2023
ВВП на душу по ППС, \$	60 927	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	16,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,28	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	9,4	2021
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	82,8	2023
Население	68,4 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.9. Франция: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	4 520	40 408	15,1
2020	4 760	39 170	16,2
2021	5 365	43 725	16,6
2022	4 858	40 989	—
2023	5 149	44 700	—

Модельная оценка. Если Франция направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$103,0 на человека в год ≈ 95 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **16,6 на 100 тыс. (2021)**: выше среднемировой (9,4) в 1,8 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,28 врача на 1 000 жителей и 9,4 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на

душу — \$60 927: в 1.4 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 82,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.5. Япония

Япония — мировой лидер по плотности психиатрических коек: **2,58 на 1 000 жителей** (ОЭСР, 2022) — вчетверо выше медианы ОЭСР (0,64) и в 32 раза больше, чем в Италии. При этом **90% коек — частные**, а 58% стационарных пациентов (2017) — люди старше 65 лет: японская психиатрическая больница исторически выполняла функцию учреждения долговременного ухода, которого в стране долго не существовало.

Главная японская история — сжатие длительности пребывания. Средняя продолжительность госпитализации (ALOS) сократилась с **~500 дней в 1990 году** до менее 300 в 2011-м и **266 дней в 2018-м** — всё ещё в десятки раз больше западноевропейской нормы, но вдвое меньше собственной исторической. Инструмент — тарифная политика: государство снижало оплату длинных пребываний и стимулировало выписку в сопровождаемое жильё.

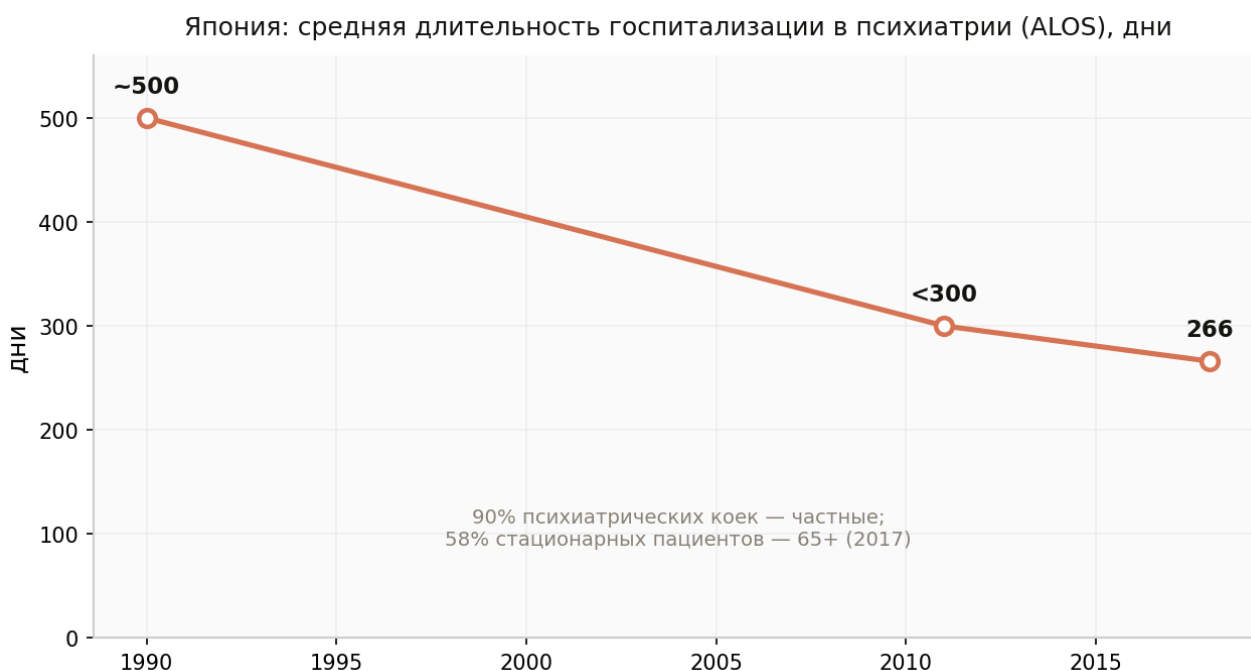


Рисунок 3.4. Япония: средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре, дни

Смертность от суицидов — 17,4 на 100 тыс. (2021), исторически высокая, хотя за двадцать лет снизилась почти вдвое. Общая коечная обеспеченность (все профили) — 12,5 на 1 000, второе место в ОЭСР после Кореи (12,6).

Вывод для семинара: Япония — живой пример «больницы как дома престарелых» и того, как тарифная политика за 30 лет выдавливает социальную функцию из лечебного учреждения обратно в социальную сферу. Прямая параллель с российскими ПНИ.

Таблица 3.10. Япония: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	3 638,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,7	2023
ВВП на душу населения, \$	35 215	2023
ВВП на душу по ППС, \$	52 726	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	17,4	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,65	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	13,0	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	84,0	2023
Население	124,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	140,49	2023

Таблица 3.11. Япония: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	4 431	41 425	16,5
2020	4 582	41 099	17,2
2021	4 844	41 581	17,4
2022	4 202	35 548	—
2023	3 638	35 215	—

Модельная оценка. Если Япония направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$72,8 на человека в год ≈ 10 223 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **17,4 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1,9 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,65 врача на 1 000 жителей и 13,0 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально построить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$52 726: в 1,5 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по

номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 84,0 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.6. Республика Корея

Республика Корея держит два тревожных рекорда выборки: самая высокая смертность от суицидов (**27,5 на 100 тыс.**, 2021 — более чем вдвое выше США) и крупнейший общий коечный фонд ОЭСР (**12,6 коек всех профилей на 1 000**). Страна с 8,6% ВВП на здравоохранение (\$3 044 на человека) построила самую «госпиталоцентричную» систему развитого мира.

Корейский парадокс — расхожий пример того, что деньги и койки не равны ментальному благополучию: экономическое чудо страны сопровождалось экстремальной учебной и трудовой конкуренцией, а суицид стал одной из ведущих причин смерти молодёжи. Государственная стратегия последнего десятилетия — масштабирование общинных кризисных центров и горячих линий, то есть переход от «больше коек» к «раньше помощь».

Вывод для семинара: Корея — контрпример к наивной формуле «больше ресурсов = лучше результат». Самая дорогая стационарная база ОЭСР соседствует с худшей суицидальной статистикой; качество помощи определяется не только объёмом, но и тем, насколько рано и насколько доступно она предлагается.

Таблица 3.12. Республика Корея: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	3 043,9	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,6	2023
ВВП на душу населения, \$	35 674	2023
ВВП на душу по ППС, \$	57 430	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	27,5	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,61	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	9,1	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,4	2023
Население	51,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	1 305,66	2023

Таблица 3.13. Республика Корея: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	2 602	33 827	28,4
2020	2 700	33 646	27,2
2021	3 126	37 518	27,5

2022	3 079	34 822	—
2023	3 044	35 674	—

Модельная оценка. Если Республика Корея направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$60,9 на человека в год** $\approx$ **79 485 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **27,5 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 2.9 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,61 врача на 1 000 жителей и 9,1 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$57 430: в 1.6 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.7. Италия

Италия — полюс, противоположный Японии: **0,08 психиатрических коек на 1 000** (ОЭСР, 2022), минимум развитого мира. Итальянская психиатрическая реформа (закон 180/1978, «закон Базалья») закрыла государственные психиатрические больницы и заменила их сетью общинных центров психического здоровья, дневных стационаров и коек при общих больницах.

Сорок пять лет спустя итальянский эксперимент остаётся главным доказательством того, что полная деинституционализация технически возможна в большой стране: психиатрическая помощь существует без «психбольниц» как класса учреждений. Цена вопроса — нагрузка на семьи и необходимость плотной сети общинных служб, без которой модель не работает. Смертность от суицидов — 7,0 на 100 тыс., одна из низких в Европе.

Вывод для семинара: Италия показывает потолок возможного: «ноль больничных коек» — не фантазия, а функционирующая модель. Но её предварительное условие — финансируемая общинная сеть; переносить «итальянский ноль» без него — значит повторить американскую трансинституционализацию.

Таблица 3.14. Италия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	3 283,5	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,4	2023
ВВП на душу населения, \$	39 280	2023
ВВП на душу по ППС, \$	60 350	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,0	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,19	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	6,8	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,4	2023
Население	59,0 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.15. Италия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	2 909	33 813	6,8
2020	3 059	32 091	6,8
2021	3 415	36 853	7,0
2022	3 155	35 654	—

2023

3 283

39 280

—

Модельная оценка. Если Италия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$65,7 на человека в год ≈ 61 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,0 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.3 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,19 врача на 1 000 жителей и 6,8 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$60 350: в 1.5 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.8. Испания

Испания — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$3 107 на человека в год** (9,2% ВВП), 20-е место из 48 стран выборки — в 2.9 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 3.16. Испания: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	3 106,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,2	2023
ВВП на душу населения, \$	33 493	2023
ВВП на душу по ППС, \$	55 661	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	8,7	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,29	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,9	2023
Население	н/д	—
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	н/д	—

Таблица 3.17. Испания: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	2 757	29 787	8,1
2020	2 942	27 234	8,6
2021	3 189	30 799	8,7
2022	2 949	30 319	—
2023	3 107	33 493	—

Модельная оценка. Если Испания направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$62,1 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **8,7 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.1 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию.

Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,29 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$55 661: в 1.7 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,9 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.9. Нидерланды

Нидерланды — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 372 на человека в год** (9,8% ВВП), 8-е место из 48 стран выборки — в 5.9 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 3.18. Нидерланды: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 371,9	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,8	2023
ВВП на душу населения, \$	63 516	2023
ВВП на душу по ППС, \$	80 392	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	11,5	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,88	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	11,7	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,9	2023
Население	17,9 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.19. Нидерланды: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 341	53 555	11,1
2020	5 866	53 468	11,1
2021	6 719	60 142	11,5
2022	5 968	59 123	—
2023	6 372	63 516	—

Модельная оценка. Если Нидерланды направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$127,4 на человека в год ≈ 118 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **11,5 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.2 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,88 врача на 1 000 жителей и 11,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$80 392: в 1.3 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,9 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.10. Бельгия

Бельгия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$5 931 на человека в год** (10,8% ВВП), 12-е место из 48 стран выборки — в 5.5 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 3.20. Бельгия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	5 931,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,8	2023
ВВП на душу населения, \$	55 245	2023
ВВП на душу по ППС, \$	72 630	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	18,4	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,57	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	12,9	2021
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	82,4	2023
Население	11,8 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.21. Бельгия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 087	46 717	18,1
2020	5 269	45 906	16,9
2021	5 847	51 658	18,4
2022	5 488	50 639	—
2023	5 931	55 245	—

Модельная оценка. Если Бельгия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$118,6 на человека в год ≈ 110 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **18,4 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.9 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем —

не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,57 врача на 1 000 жителей и 12,9 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$72 630: в 1.3 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 82,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.11. Австрия

Австрия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 268 на человека в год** (11,2% ВВП), 9-е место из 48 стран выборки — в 5.8 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 3.22. Австрия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 267,9	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,2	2023
ВВП на душу населения, \$	56 580	2023
ВВП на душу по ППС, \$	74 261	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	14,5	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	5,51	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	11,3	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,8	2023
Население	9,1 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 3.23. Австрия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 313	49 886	14,6
2020	5 570	48 716	14,0
2021	6 554	53 649	14,5
2022	5 898	52 337	—
2023	6 268	56 580	—

Модельная оценка. Если Австрия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$125,4 на человека в год ≈ 116 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **14,5 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 5,51 врача на 1 000 жителей и 11,3 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$74 261: в 1.3 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

3.12. Швеция

Швеция — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 206 на человека в год** (11,2% ВВП), 10-е место из 48 стран выборки — в 5.7 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 3.24. Швеция: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 206,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,2	2023
ВВП на душу населения, \$	54 950	2023
ВВП на душу по ППС, \$	68 458	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	13,8	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,41	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,3	2023
Население	10,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	10,61	2023

Таблица 3.25. Швеция: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 688	51 649	14,6
2020	6 031	52 569	13,4
2021	6 894	60 648	13,8
2022	6 022	54 837	—
2023	6 206	54 950	—

Модельная оценка. Если Швеция направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$124,1 на человека в год ≈ 1 317 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **13,8 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,41 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально построить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$68 458: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,3 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

Развитые страны: продолжение — северные модели и новые члены клуба

Вторая дюжина развитых стран интересна прежде всего скандинавским блоком — самой дорогой социальной моделью мира — и странами, чья психиатрия недавно прошла болезненные реформы (Греция, Польша, Чехия). Здесь же — Израиль с его уникальной легализованной реабилитацией.

Таблица 4.1. Развитые страны (вторая дюжина): базовые показатели (Всемирный банк)

Страна	Расходы на здравоохран., \$/чел.	% ВВП	Суициды, на 100 тыс.
Норвегия	8 296	9,4	13,2
Финляндия	5 515	10,5	14,6
Дания	6 511	9,6	10,5
Исландия	7 065	8,7	11,9
Ирландия	6 878	6,6	8,6
Греция	1 963	8,4	4,7
Польша	1 578	7,1	13,7
Чехия	2 671	8,4	13,3
Канада	6 187	11,2	9,4
Австралия	6 980	10,4	13,1
Новая Зеландия	4 997	10,1	11,9
Израиль	3 928	7,1	4,4

4.1. Норвегия

Норвегия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$8 296 на человека в год** (9,4% ВВП), 2-е место из 48 стран выборки — в 7.6 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.2. Норвегия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	8 296,4	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,4	2023
ВВП на душу населения, \$	90 984	2023
ВВП на душу по ППС, \$	107 768	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	13,2	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,97	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	16,5	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,0	2023
Население	5,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	10,56	2023

Таблица 4.3. Норвегия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	8 007	79 329	12,6
2020	7 825	71 058	12,5
2021	9 163	96 443	13,2
2022	8 693	113 122	—
2023	8 296	90 984	—

Модельная оценка. Если Норвегия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$165,9 на человека в год ≈ 1 753 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **13,2 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,97 врача на 1 000 жителей и 16,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$107 768: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,0 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.2. Финляндия

Финляндия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$5 515 на человека в год** (10,5% ВВП), 13-е место из 48 стран выборки — в 5.1 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.4. Финляндия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	5 515,4	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,5	2023
ВВП на душу населения, \$	52 865	2023
ВВП на душу по ППС, \$	63 467	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	14,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,61	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	14,0	2021
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,6	2023
Население	5,6 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 4.5. Финляндия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	4 460	48 358	14,4
2020	4 736	48 829	14,1
2021	5 262	53 099	14,6
2022	4 902	50 441	—
2023	5 515	52 865	—

Модельная оценка. Если Финляндия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$110,3 на человека в год ≈ 102 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **14,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,61 врача на 1 000 жителей и 14,0 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$63 467: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.3. Дания

Дания — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 511 на человека в год** (9,6% ВВП), 6-е место из 48 стран выборки — в 6.0 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.6. Дания: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 510,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,6	2023
ВВП на душу населения, \$	68 044	2023
ВВП на душу по ППС, \$	77 425	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	10,5	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,50	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	12,2	2021
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,8	2023
Население	5,9 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	6,89	2023

Таблица 4.7. Дания: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	6 050	59 404	11,4
2020	6 521	60 985	10,9
2021	7 430	69 341	10,5
2022	6 451	67 781	—
2023	6 511	68 044	—

Модельная оценка. Если Дания направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$130,2 на человека в год ≈ 897 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **10,5 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.1 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,50 врача на 1 000 жителей и 12,2 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$77 425: в 1.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.4. Исландия

Исландия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$7 065 на человека в год** (8,7% ВВП), 3-е место из 48 стран выборки — в 6.5 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.8. Исландия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	7 064,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,7	2023
ВВП на душу населения, \$	82 201	2023
ВВП на душу по ППС, \$	82 257	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	11,9	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,37	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	15,9	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	82,5	2023
Население	0,4 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	137,94	2023

Таблица 4.9. Исландия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 912	69 296	12,0
2020	5 693	60 128	12,9
2021	6 722	70 425	11,9
2022	6 852	76 377	—
2023	7 065	82 201	—

Модельная оценка. Если Исландия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$141,3 на человека в год ≈ 19 490 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **11,9 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.3 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,37 врача на 1 000 жителей и 15,9 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 82,5 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.5. Ирландия

Ирландия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 878 на человека в год** (6,6% ВВП), 5-е место из 48 стран выборки — в 6.3 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.10. Ирландия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 877,9	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	6,6	2023
ВВП на душу населения, \$	106 819	2023
ВВП на душу по ППС, \$	133 440	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	8,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,88	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	14,8	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	82,8	2023
Население	5,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 4.11. Ирландия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 454	81 828	8,1
2020	6 073	86 514	8,6
2021	6 754	103 783	8,6
2022	6 408	105 191	—
2023	6 878	106 819	—

Модельная оценка. Если Ирландия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$137,6 на человека в год ≈ 127 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **8,6 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.1 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию.

Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,88 врача на 1 000 жителей и 14,8 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$133 440: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 82,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.6. Греция

Греция — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$1 963 на человека в год** (8,4% ВВП), 23-е место из 48 стран выборки — в 1.8 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.12. Греция: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	1 962,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,4	2023
ВВП на душу населения, \$	23 344	2023
ВВП на душу по ППС, \$	42 614	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	4,7	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	6,58	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	4,1	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,7	2023
Население	10,4 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	0,92	2023

Таблица 4.13. Греция: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	1 569	19 335	5,1
2020	1 675	17 887	4,4
2021	1 846	20 653	4,7
2022	1 768	20 885	—
2023	1 963	23 344	—

Модельная оценка. Если Греция направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$39,3 на человека в год ≈ 36 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **4,7 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 2.0 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 6,58 врача на 1 000 жителей и 4,1 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$42 614: в 1.8 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,7 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.7. Польша

Польша — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$1 578 на человека в год** (7,1% ВВП), 25-е место из 48 стран выборки — в 1.5 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.14. Польша: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	1 578,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	7,1	2023
ВВП на душу населения, \$	22 145	2023
ВВП на душу по ППС, \$	48 473	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	13,7	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,03	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	78,3	2023
Население	36,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	4,20	2023

Таблица 4.15. Польша: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	1 014	15 875	13,7
2020	1 026	16 151	13,9
2021	1 183	18 636	13,7
2022	1 219	18 891	—
2023	1 578	22 145	—

Модельная оценка. Если Польша направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$31,6 на человека в год ≈ 133 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **13,7 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,03 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$48 473: в 2.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 78,3 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.8. Чехия

Чехия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$2 671 на человека в год** (8,4% ВВП), 22-е место из 48 стран выборки — в 2.5 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.16. Чехия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	2 671,1	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,4	2023
ВВП на душу населения, \$	31 762	2023
ВВП на душу по ППС, \$	56 062	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	13,3	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,35	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	9,5	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	79,8	2023
Население	10,9 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	22,20	2023

Таблица 4.17. Чехия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	1 805	24 063	12,2
2020	2 106	23 473	12,7
2021	2 538	27 696	13,3
2022	2 431	28 282	—
2023	2 671	31 762	—

Модельная оценка. Если Чехия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$53,4 на человека в год ≈ 1 186 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **13,3 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,35 врача на 1 000 жителей и 9,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$56 062: в 1.8 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 79,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.9. Канада

Канада — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 187 на человека в год** (11,2% ВВП), 11-е место из 48 стран выборки — в 5.7 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.18. Канада: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 186,7	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	11,2	2023
ВВП на душу населения, \$	54 848	2023
ВВП на душу по ППС, \$	64 962	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	9,4	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,82	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	11,3	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,6	2023
Население	40,0 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	1,35	2023

Таблица 4.19. Канада: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 099	46 353	12,7
2020	5 646	43 538	11,6
2021	6 511	52 887	9,4
2022	6 252	56 497	—
2023	6 187	54 848	—

Модельная оценка. Если Канада направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$123,7 на человека в год ≈ 167 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **9,4 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.0 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,82 врача на 1 000 жителей и 11,3 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$64 962: в 1.2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.10. Австралия

Австралия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$6 980 на человека в год** (10,4% ВВП), 4-е место из 48 стран выборки — в 6.4 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.20. Австралия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	6 980,4	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,4	2023
ВВП на душу населения, \$	65 058	2023
ВВП на душу по ППС, \$	72 273	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	13,1	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,09	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	13,4	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,1	2023
Население	26,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	1,51	2023

Таблица 4.21. Австралия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	5 543	55 195	14,0
2020	5 968	51 983	13,0
2021	7 092	60 759	13,1
2022	6 724	65 170	—
2023	6 980	65 058	—

Модельная оценка. Если Австралия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$139,6 на человека в год ≈ 210 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **13,1 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,09 врача на 1 000 жителей и 13,4 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$72 273: в 1.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,1 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.11. Новая Зеландия

Новая Зеландия — страна с высоким доходом: расходы на здравоохранение **\$4 997 на человека в год** (10,1% ВВП), 16-е место из 48 стран выборки — в 4.6 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 4.22. Новая Зеландия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	4 997,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,1	2023
ВВП на душу населения, \$	49 302	2023
ВВП на душу по ППС, \$	54 950	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	11,9	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,61	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	12,3	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,8	2023
Население	5,2 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	1,63	2023

Таблица 4.23. Новая Зеландия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	3 680	42 872	11,8
2020	3 888	42 055	11,3
2021	4 749	49 902	11,9
2022	5 138	49 142	—
2023	4 997	49 302	—

Модельная оценка. Если Новая Зеландия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$99,9 на человека в год ≈ 163 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **11,9 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.3 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и

реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,61 врача на 1 000 жителей и 12,3 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$54 950: в 1.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

4.12. Израиль

Израиль — страна с аномально низкой смертностью от суицидов для своего уровня стресса: **4,4 на 100 тыс.** (2021) — одно из низших значений выборки, при заметных расходах на здравоохранение (\$3 928 на человека, 7,1% ВВП).

Стоимость года жизни пациента с тяжёлым психическим расстройством — **€6 955** (пятистранное исследование 2022 года), второе место после Германии. Израильская специфика — развитая реабилитационная ветвь (закон о реабилитации инвалидов с психическими расстройствами 2000 года создал корзину услуг: жильё, занятость, образование), финансируемую отдельно от лечебной. Это редкий пример страны, где «социальная» часть помощи легализована как отдельное право с отдельным бюджетом.

Вывод для семинара: израильская двухконтурная модель «лечение + легализованная реабилитация» — ближайший аналог связки «Минздрав + Минтруд», к которой движется и российская система.

Таблица 4.24. Израиль: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	3 927,7	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	7,1	2023
ВВП на душу населения, \$	52 126	2023
ВВП на душу по ППС, \$	55 301	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	4,4	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,80	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	5,9	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	83,2	2023
Население	9,8 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	3,67	2023

Таблица 4.25. Израиль: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	3 335	44 092	5,0
2020	3 617	44 591	5,1
2021	4 294	52 258	4,4
2022	4 108	54 947	—
2023	3 928	52 126	—

Модельная оценка. Если Израиль направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$78,6 на человека в год $\approx$ 288 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **4,4 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 2.2 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Расходы выше \$3 000 на человека позволяют полный набор: стационары, кризисные службы, сопровождаемое проживание и реабилитацию. Ключевая проблема таких систем — не доступность, а эффективность и очереди (как в Великобритании с её 1,8 млн ждущих помощи).

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,80 врача на 1 000 жителей и 5,9 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$55 301: в 1.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 83,2 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

Развивающийся мир: помощь по цене чашки кофе

Двадцать три страны этой части — от Украины до Бангладеш — тратят на здравоохранение от \$30 до \$1 700 на человека. Именно здесь живёт большинство населения Земли и именно здесь «мировая медиана \$2,69 на психическое здоровье» ощущается не как статистика, а как ежедневная реальность. Эти профили важны не только контрастом: Бразилия, Казахстан и Китай показывают рабочие модели помощи при ресурсах, сопоставимых с российскими.

Таблица 5.1. Развивающиеся страны: базовые показатели (Всемирный банк)

Страна	Расходы на здравоохран., \$/чел.	% ВВП	Суициды, на 100 тыс.
Украина	370	8,2	21,2
Беларусь	558	7,1	15,6
Казахстан	490	3,8	14,6
Грузия	554	6,9	5,1
Армения	767	9,3	2,5
Китай	763	5,9	8,9
Индия	85	3,3	12,6
Индонезия	132	2,7	1,2
Таиланд	327	н/д	16,6
Вьетнам	197	н/д	7,3
Бразилия	1 010	9,7	7,6
Мексика	761	5,5	7,0
Аргентина	1 457	10,3	7,9
Чили	1 737	10,2	7,7
Колумбия	571	8,2	5,0
Турция	548	н/д	2,7
ЮАР	537	н/д	22,3
Нигерия	67	4,2	5,0
Египет	141	4,9	0,6
Кения	85	4,4	4,6
Эфиопия	35	2,8	6,1
Пакистан	30	2,5	5,6
Бангладеш	53	2,2	2,8

5.1. Украина

Украина входит в выборку с самой тяжёлой суицидальной статистикой после России: **21,2 на 100 тыс.** (2021). Расходы на здравоохранение — \$370 на человека при 8,2% ВВП (2023) — экономика военного времени перераспределяет ресурсы, и данные за 2022–2023 годы отражают экстраординарные условия.

Украинская психиатрическая сеть унаследовала постсоветскую структуру (областные больницы, ПНД, интернаты) и до 2022 года двигалась по пути реформы «доступная помощь в общине» при поддержке ВОЗ. Военная травматизация населения резко подняла спрос: международные оценки последних лет сходятся в том, что потребность в психологической помощи затронула миллионы человек — это фон, на котором любые довоенные цифры следует читать с осторожностью.

Вывод для семинара: украинский кейс напоминает: запас прочности системы психической помощи проверяется не в мирное время, а при массовой травме — и строить этот запас нужно заранее.

Таблица 5.2. Украина: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	369,9	2021
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,2	2021
ВВП на душу населения, \$	5 140	2023
ВВП на душу по ППС, \$	17 680	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	21,2	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,53	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	73,4	2023
Население	37,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	36,57	2023

Таблица 5.3. Украина: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохр., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	243	3 620	23,3
2020	265	3 710	22,1
2021	370	4 776	21,2
2022	—	4 200	—
2023	—	5 140	—

Модельная оценка. Если Украина направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$7,4 на человека в год $\approx$ 271 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **21,2 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 2.3 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,53 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально построить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$17 680: в 3.4 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 73,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.2. Беларусь

Беларусь — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$558 на человека в год** (7,1% ВВП), 33-е место из 48 стран выборки — в 1.9 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.4. Беларусь: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	558,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	7,1	2023
ВВП на душу населения, \$	7 897	2023
ВВП на душу по ППС, \$	30 860	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	15,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	4,72	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	10,8	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	74,2	2023
Население	9,2 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	3,01	2023

Таблица 5.5. Беларусь: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	400	6 838	17,5
2020	420	6 543	16,3
2021	484	7 490	15,6
2022	529	7 995	—
2023	558	7 897	—

Модельная оценка. Если Беларусь направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$11,2 на человека в год ≈ 34 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **15,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.7 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 4,72 врача на 1 000 жителей и 10,8 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$30 860: в 3.9 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 74,2 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.3. Казахстан

Казахстан — ближайший к России «зеркальный» кейс: постсоветская стационарная система с сопоставимой коечной базой. В 2019 году в стране было **7 846 психиатрических коек** — 4,2 на 10 тыс. жителей (для сравнения: в России — 8,4 на 10 тыс. в 2023-м).

Два показателя качества выделяют казахстанскую статистику: средняя длительность пребывания взрослых — **51,4 дня** (заметно меньше исторических постсоветских норм, но вдвое выше западноевропейских) и доля повторных госпитализаций — **46,7%**: почти каждая вторая госпитализация — возврат пациента. «Вращающаяся дверь» такой интенсивности означает, что система лечит обострения, но не удерживает ремиссию — недостаток именно общинного звена.

Расходы на здравоохранение — \$490 на человека (3,8% ВВП, 2023) — при ВВП на душу \$12 879: Казахстан тратит на здоровье непропорционально мало для своего богатства. Смертность от суицидов — 14,6 на 100 тыс.

Вывод для семинара: показатель «46,7% повторных госпитализаций» — готовый КРІ для любой системы: снижение доли возвратов — самый дешёвый способ высвободить койки без сокращения помощи.

Таблица 5.6. Казахстан: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	489,7	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	3,8	2023
ВВП на душу населения, \$	12 879	2023
ВВП на душу по ППС, \$	38 547	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	14,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,75	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	6,5	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	74,4	2023
Население	20,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	456,17	2023

Таблица 5.7. Казахстан: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	264	9 457	18,8
2020	330	8 782	17,0
2021	392	9 984	14,6

2022	422	11 255	—
2023	490	12 879	—

Модельная оценка. Если Казахстан направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$9,8 на человека в год $\approx$ 4 468 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **14,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,75 врача на 1 000 жителей и 6,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$38 547: в 3.0 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 74,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.4. Грузия

Грузия — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$554 на человека в год** (6,9% ВВП), 34-е место из 48 стран выборки — в 2.0 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.8. Грузия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	554,3	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	6,9	2023
ВВП на душу населения, \$	8 284	2023
ВВП на душу по ППС, \$	25 093	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	5,1	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	5,64	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	6,0	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	74,5	2023
Население	3,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	2,63	2023

Таблица 5.9. Грузия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	340	4 741	7,3
2020	389	4 301	5,7
2021	524	5 084	5,1
2022	546	6 730	—
2023	554	8 284	—

Модельная оценка. Если Грузия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$11,1 на человека в год ≈ 29 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **5,1 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.8 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 5,64 врача на 1 000 жителей и 6,0 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$25 093: в 3.0 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 74,5 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.5. Армения

Армения — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$767 на человека в год** (9,3% ВВП), 29-е место из 48 стран выборки — в 1.4 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.10. Армения: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	767,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,3	2023
ВВП на душу населения, \$	8 159	2023
ВВП на душу по ППС, \$	21 552	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	2,5	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,36	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	4,7	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	77,5	2023
Население	3,0 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	392,48	2023

Таблица 5.11. Армения: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	534	4 597	2,7
2020	535	4 269	2,2
2021	596	4 685	2,5
2022	675	6 572	—
2023	767	8 159	—

Модельная оценка. Если Армения направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$15,3 на человека в год ≈ 6 020 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **2,5 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 3.8 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,36 врача на 1 000 жителей и 4,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$21 552: в 2.6 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 77,5 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.6. Китай

Китай — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$763 на человека в год** (5,9% ВВП), 30-е место из 48 стран выборки — в 1.4 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.12. Китай: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	763,4	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	5,9	2023
ВВП на душу населения, \$	12 951	2023
ВВП на душу по ППС, \$	25 200	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	8,9	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,11	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	3,7	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	78,0	2023
Население	1 410,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	7,08	2023

Таблица 5.13. Китай: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	539	10 343	8,8
2020	583	10 627	8,8
2021	670	12 887	8,9
2022	755	12 971	—
2023	763	12 951	—

Модельная оценка. Если Китай направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$15,3 на человека в год ≈ 108 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **8,9 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.1 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,11 врача на 1 000 жителей и 3,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$25 200: в 1.9 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 78,0 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.7. Индия

Индия — самая яркая иллюстрация масштаба недофинансирования: бюджет на психическое здоровье на FY2025-26 — **₹1 180 крор** (около \$140 млн), что составляет **1,18%** бюджета Минздрава страны (₹99 859 крор). На 1,44 млрд жителей это **около 10 центов на человека в год**.

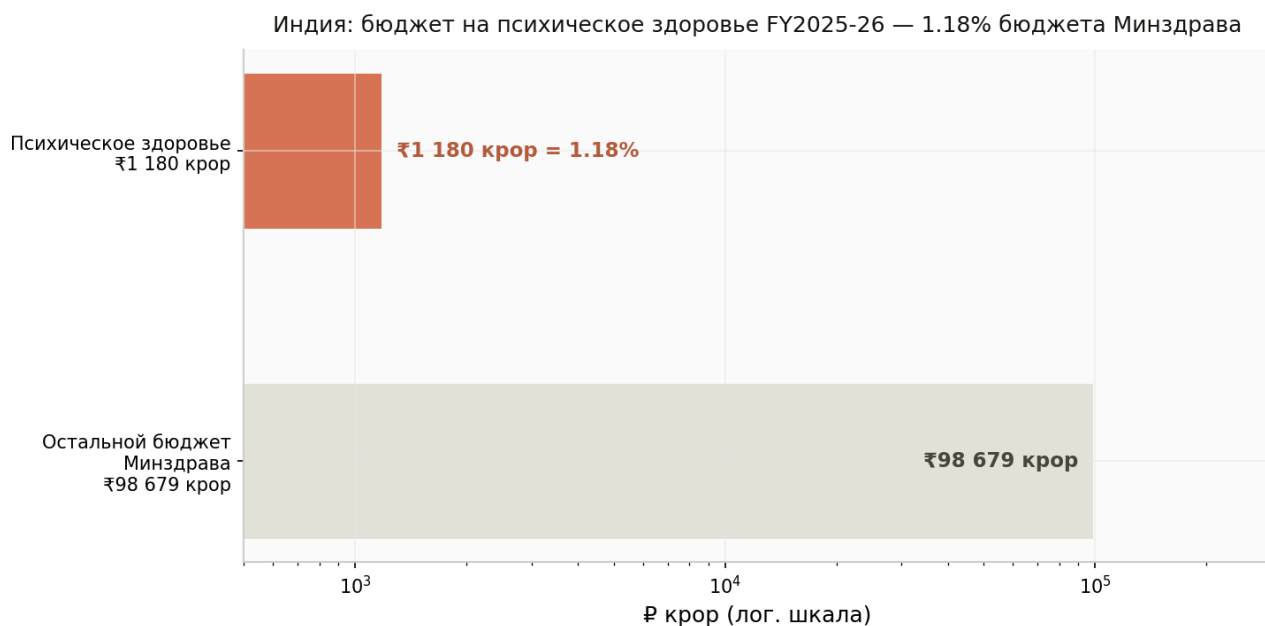


Рисунок 5.1. Индия: бюджет на психическое здоровье в масштабе бюджета Минздрава, FY2025-26

Структура этих скромных денег ещё показательнее: в 2022 году 94% бюджета психического здоровья ушло на два федеральных института (NIMHANS в Бангалоре и LGBRIMH в Тезпуре), а на районную программу DMHP, покрывающую 767 округов, остались проценты. При этом в 2015–2021 годах округа освоили лишь **38%** выделенных им средств — деньги есть, а механизм их превращения в помощь не выстроен. Разрыв в лечении в Индии — **70–92%** в зависимости от расстройства: это худшие надёжно измеренные значения среди крупных стран.

Стоимость года жизни пациента с тяжёлым расстройством в Индии — **€1 013** (пятистратное исследование 2022 года) — вдесятеро дешевле Германии, но и объём помощи несопоставимо меньше. Отраслевой поворот: в бюджете 2026-27 объявлено создание NIMHANS 2.0 — расширение флагманского института в попытке нарастить кадры и исследования.

Вывод для семинара: Индия учит отличать «бюджет выделен» от «помощь оказана»: освоение 38% средств — симптом, знакомый любому российскому учреждению, живущему с госзадаанием. Недоосвоение — не экономия, а неоказанная помощь.

Таблица 5.14. Индия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	84,7	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	3,3	2023
ВВП на душу населения, \$	2 434	2023
ВВП на душу по ППС, \$	9 853	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	12,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,72	2020
Медсестры и акушеры, на 1 000	1,7	2020
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	72,0	2023
Население	1 438,1 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	82,60	2023

Таблица 5.15. Индия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	61	2 041	14,0
2020	64	1 907	13,0
2021	76	2 240	12,6
2022	82	2 280	—
2023	85	2 434	—

Модельная оценка. Если Индия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$1,7 на человека в год ≈ 140 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **12,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.3 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено (подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,72 врача на 1 000 жителей и 1,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$9 853: в 4.0 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже

долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 72,0 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.8. Индонезия

Индонезия — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$132 на человека в год** (2,7% ВВП), 42-е место из 48 стран выборки — в 8.2 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.16. Индонезия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	131,8	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	2,7	2023
ВВП на душу населения, \$	4 876	2023
ВВП на душу по ППС, \$	15 428	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	1,2	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,52	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	3,2	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	71,1	2023
Население	281,2 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	15 236,88	2023

Таблица 5.17. Индонезия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	118	4 107	1,6
2020	132	3 854	1,4
2021	159	4 287	1,2
2022	127	4 731	—
2023	132	4 876	—

Модельная оценка. Если Индонезия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$2,6 на человека в год ≈ 40 158 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **1,2 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 7.9 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,52 врача на 1 000 жителей и 3,2 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$15 428: в 3,2 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 71,1 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.9. Таиланд

Таиланд — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$327 на человека в год**, 39-е место из 48 стран выборки — в 3.3 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.18. Таиланд: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	326,5	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	н/д	—
ВВП на душу населения, \$	7 211	2023
ВВП на душу по ППС, \$	н/д	—
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	16,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,54	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	76,4	2023
Население	71,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	н/д	—

Таблица 5.19. Таиланд: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	288	7 606	13,6
2020	304	6 983	15,5
2021	364	7 055	16,6
2022	370	6 910	—
2023	327	7 211	—

Модельная оценка. Если Таиланд направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$6,5 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **16,6 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 1.8 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,54 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 76,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.10. Вьетнам

Вьетнам — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$197 на человека в год**, 40-е место из 48 стран выборки — в 5.5 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.20. Вьетнам: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	197,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	н/д	—
ВВП на душу населения, \$	4 323	2023
ВВП на душу по ППС, \$	н/д	—
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,3	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	1,11	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	74,6	2023
Население	100,4 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	н/д	—

Таблица 5.21. Вьетнам: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	171	3 441	7,5
2020	153	3 534	6,8
2021	168	3 704	7,3
2022	188	4 148	—
2023	197	4 323	—

Модельная оценка. Если Вьетнам направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$3,9 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,3 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.3 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 1,11 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 74,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.11. Бразилия

Бразилия — главный южноамериканский кейс деинституционализации. Закон 10.216 (2001 год) поставил целью замену психиатрических больниц общинной сетью CAPS (центры психосоциальной помощи). Результат за 12 лет: коечный фонд сокращён с **51 393 (2002)** до **25 988 коек (2014)** — минус 58%; доля федерального финансирования общинной помощи выросла с 24,8% до **79,4%**; покрытие CAPS — с 0,21 до 0,90 на 100 тыс. жителей.

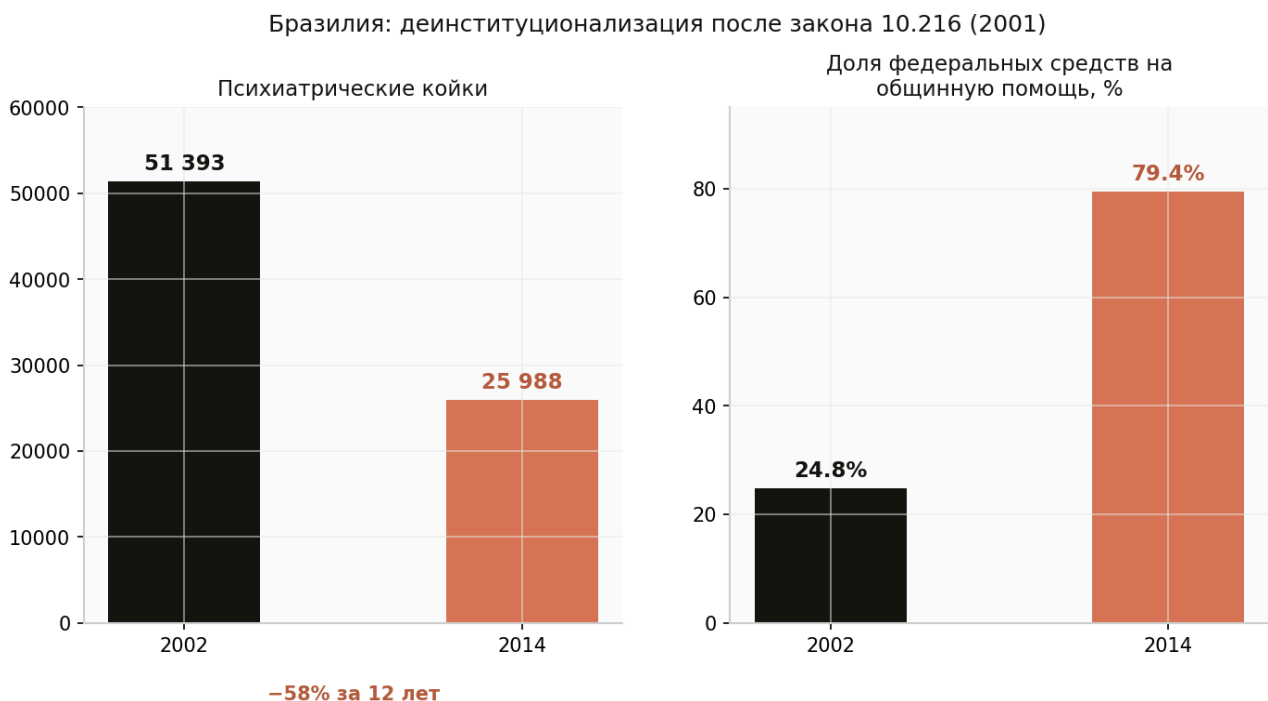


Рисунок 5.2. Бразилия: коечный фонд и структура финансирования после реформы 2001 года

Для выписанных после длительных госпитализаций создана программа «Volta para Casa» («Возвращение домой») — ежемесячное реабилитационное пособие **R\$709,25** (около \$140 по курсу 2023 года), позволяющее бывшим пациентам жить вне больницы. Это один из немногих в мире примеров прямой денежной поддержки деинституционализации — дешевле койки и гуманнее.

Смертность от суицидов — 7,6 на 100 тыс., ниже мировой медианы. Бразилия тратит на здравоохранение 9,7% ВВП (\$1 010 на человека) — уровень, близкий к российскому, что делает её опыт особенно релевантным для сравнения.

Вывод для семинара: бразильская формула «койка → CAPS + денежное пособие» — рабочая модель переноса денег вслед за человеком. Пособие «Возвращение домой» стоит системе дешевле койко-месяца и возвращает человеку адрес, а системе — койку.

Таблица 5.22. Бразилия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	1 009,8	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	9,7	2023
ВВП на душу населения, \$	10 378	2023
ВВП на душу по ППС, \$	21 193	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,36	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	5,5	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	75,8	2023
Население	211,1 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	4,99	2023

Таблица 5.23. Бразилия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	868	9 030	6,7
2020	681	7 074	6,9
2021	768	7 973	7,6
2022	871	9 281	—
2023	1 010	10 378	—

Модельная оценка. Если Бразилия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$20,2 на человека в год** $\approx$ **101 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,6 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.2 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,36 врача на 1 000 жителей и 5,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$21 193: в 2.0 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу.

Ожидаемая продолжительность жизни — 75,8 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.12. Мексика

Мексика — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$761 на человека в год** (5,5% ВВП), 31-е место из 48 стран выборки — в 1.4 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.24. Мексика: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	761,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	5,5	2023
ВВП на душу населения, \$	13 831	2023
ВВП на душу по ППС, \$	25 188	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,0	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,59	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	3,0	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	75,1	2023
Население	129,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	17,76	2023

Таблица 5.25. Мексика: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	550	10 370	6,2
2020	535	8 841	6,4
2021	606	10 314	7,0
2022	651	11 406	—
2023	761	13 831	—

Модельная оценка. Если Мексика направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$15,2 на человека в год ≈ 270 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,0 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,59 врача на 1 000 жителей и 3,0 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$25 188: в 1.8 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 75,1 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.13. Аргентина

Аргентина — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$1 457 на человека в год** (10,3% ВВП), 26-е место из 48 стран выборки — в 1.3 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.26. Аргентина: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	1 457,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,3	2023
ВВП на душу населения, \$	14 262	2023
ВВП на душу по ППС, \$	30 246	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,9	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	5,11	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	4,7	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	77,4	2023
Население	45,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	296,26	2023

Таблица 5.27. Аргентина: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	1 007	9 956	9,3
2020	911	8 536	8,1
2021	1 182	10 738	7,9
2022	1 416	13 962	—
2023	1 457	14 262	—

Модельная оценка. Если Аргентина направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$29,1 на человека в год ≈ 8 633 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,9 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.2 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 5,11 врача на 1 000 жителей и 4,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$30 246: в 2.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 77,4 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.14. Чили

Чили — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$1 737 на человека в год** (10,2% ВВП), 24-е место из 48 стран выборки — в 1.6 раза выше среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.28. Чили: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	1 736,5	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	10,2	2023
ВВП на душу населения, \$	17 082	2023
ВВП на душу по ППС, \$	33 174	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	7,7	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	3,33	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	5,5	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	81,2	2023
Население	19,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	840,07	2023

Таблица 5.29. Чили: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	1 349	14 497	9,8
2020	1 271	13 118	8,3
2021	1 577	16 216	7,7
2022	1 541	15 399	—
2023	1 737	17 082	—

Модельная оценка. Если Чили направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$34,7 на человека в год** ≈ **29 176 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **7,7 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.2 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Диапазон \$800–3 000 на человека — зона активного выбора модели: ресурсов хватает и на стационары, и на общинные службы, и главный вопрос — пропорции между ними.

Кадровый фон системы здравоохранения: 3,33 врача на 1 000 жителей и 5,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$33 174: в 1.9 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.15. Колумбия

Колумбия — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$571 на человека в год** (8,2% ВВП), 32-е место из 48 стран выборки — в 1.9 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.30. Колумбия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	571,2	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	8,2	2023
ВВП на душу населения, \$	7 012	2023
ВВП на душу по ППС, \$	21 282	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	5,0	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,54	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	1,5	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	77,7	2023
Население	52,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	4 325,95	2023

Таблица 5.31. Колумбия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	507	6 473	5,1
2020	464	5 340	4,8
2021	569	6 223	5,0
2022	507	6 680	—
2023	571	7 012	—

Модельная оценка. Если Колумбия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$11,4 на человека в год** ≈ **49 416 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **5,0 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.9 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,54 врача на 1 000 жителей и 1,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$21 282: в 3.0 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 77,7 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.16. Турция

Турция — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$548 на человека в год** , 35-е место из 48 стран выборки — в 2.0 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.32. Турция: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	547,8	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	н/д	—
ВВП на душу населения, \$	13 375	2023
ВВП на душу по ППС, \$	н/д	—
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	2,7	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	2,24	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	77,2	2023
Население	85,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	н/д	—

Таблица 5.33. Турция: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	389	9 395	3,5
2020	386	8 798	3,0
2021	431	9 982	2,7
2022	386	10 898	—
2023	548	13 375	—

Модельная оценка. Если Турция направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$11,0 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **2,7 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 3.5 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 2,24 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 77,2 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.17. ЮАР

ЮАР — страна с выше среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$537 на человека в год**, 36-е место из 48 стран выборки — в 2.0 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.34. ЮАР: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	536,6	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	н/д	—
ВВП на душу населения, \$	6 034	2023
ВВП на душу по ППС, \$	н/д	—
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	22,3	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,79	2022
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	66,1	2023
Население	63,2 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	н/д	—

Таблица 5.35. ЮАР: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	539	6 534	20,1
2020	503	5 581	21,1
2021	593	6 829	22,3
2022	570	6 534	—
2023	537	6 034	—

Модельная оценка. Если ЮАР направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$10,7 на человека в год**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **22,3 на 100 тыс.** (2021): выше среднемировой (9,4) в 2.4 раза. Это сигнал повышенного неудовлетворённого спроса на помощь. Системы этого диапазона (\$200–800 на человека) обычно держатся на стационарном ядре: дешевле содержать больницу, чем строить разветвлённую общинную сеть, — и потому реформы здесь идут медленнее всего.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,79 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. Ожидаемая продолжительность жизни — 66,1 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.18. Нигерия

Нигерия — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$67 на человека в год** (4,2% ВВП), 45-е место из 48 стран выборки — в 16.2 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.36. Нигерия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	66,8	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	4,2	2023
ВВП на душу населения, \$	2 139	2023
ВВП на душу по ППС, \$	8 712	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	5,0	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,38	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	1,6	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	54,5	2023
Население	227,9 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	645,19	2023

Таблица 5.37. Нигерия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	68	3 190	4,4
2020	68	2 797	4,6
2021	82	2 787	5,0
2022	90	2 899	—
2023	67	2 139	—

Модельная оценка. Если Нигерия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$1,3 на человека в год ≈ 862 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **5,0 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.9 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,38 врача на 1 000 жителей и 1,6 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$8 712: в 4.1 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 54,5 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.19. Египет

Египет — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$141 на человека в год** (4,9% ВВП), 41-е место из 48 стран выборки — в 7.7 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.38. Египет: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	141,4	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	4,9	2023
ВВП на душу населения, \$	3 457	2023
ВВП на душу по ППС, \$	18 540	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	0,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,67	2020
Медсестры и акушеры, на 1 000	н/д	—
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	71,6	2023
Население	114,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	30,63	2023

Таблица 5.39. Египет: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	143	2 963	0,9
2020	148	3 511	0,8
2021	177	3 827	0,6
2022	172	4 233	—
2023	141	3 457	—

Модельная оценка. Если Египет направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$2,8 на человека в год ≈ 87 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **0,6 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 15.0 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической

помощи в первичное звено (подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,67 врача на 1 000 жителей. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально построить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$18 540: в 5.4 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 71,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.20. Кения

Кения — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$85 на человека в год** (4,4% ВВП), 43-е место из 48 стран выборки — в 12.8 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.40. Кения: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	85,0	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	4,4	2023
ВВП на душу населения, \$	1 943	2023
ВВП на душу по ППС, \$	6 322	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	4,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,29	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	2,3	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	63,6	2023
Население	55,3 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	139,85	2023

Таблица 5.41. Кения: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	86	1 960	6,5
2020	87	1 928	5,6
2021	94	2 061	4,6
2022	91	2 110	—
2023	85	1 943	—

Модельная оценка. Если Кения направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$1,7 на человека в год ≈ 238 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **4,6 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 2.1 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,29 врача на 1 000 жителей и 2,3 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$6 322: в 3.3 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 63,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.21. Эфиопия

Эфиопия — страна с низким доходом: расходы на здравоохранение **\$35 на человека в год** (2,8% ВВП), 47-е место из 48 стран выборки — в 31.2 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.42. Эфиопия: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	34,8	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	2,8	2023
ВВП на душу населения, \$	1 056	2023
ВВП на душу по ППС, \$	3 063	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	6,1	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,14	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	1,2	2022
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	67,3	2023
Население	128,7 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	54,60	2023

Таблица 5.43. Эфиопия: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	26	793	5,7
2020	28	830	5,7
2021	26	893	6,1
2022	27	982	—
2023	35	1 056	—

Модельная оценка. Если Эфиопия направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$0,7 на человека в год ≈ 38 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **6,1 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.6 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,14 врача на 1 000 жителей и 1,2 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$3 063: в 2.9 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 67,3 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.22. Пакистан

Пакистан — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$30 на человека в год** (2,5% ВВП), 48-е место из 48 стран выборки — в 35.6 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.44. Пакистан: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	30,5	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	2,5	2023
ВВП на душу населения, \$	1 360	2023
ВВП на душу по ППС, \$	6 019	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	5,6	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	1,16	2021
Медсестры и акушеры, на 1 000	0,5	2021
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	67,6	2023
Население	247,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	280,36	2023

Таблица 5.45. Пакистан: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	36	1 390	6,1
2020	37	1 278	5,4
2021	43	1 455	5,6
2022	39	1 538	—
2023	30	1 360	—

Модельная оценка. Если Пакистан направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$0,6 на человека в год ≈ 171 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **5,6 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 1.7 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 1,16 врача на 1 000 жителей и 0,5 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$6 019: в 4,4 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 67,6 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.23. Бангладеш

Бангладеш — страна с ниже среднего доходом: расходы на здравоохранение **\$53 на человека в год** (2,2% ВВП), 46-е место из 48 стран выборки — в 20.3 раза ниже среднемирового уровня (~\$1 085). Всё, что система может позволить себе в психиатрии, вырезается из этой базовой цифры.

Таблица 5.46. Бангладеш: ключевые показатели (Всемирный банк, последние доступные годы)

Показатель	Значение	Год
Расходы на здравоохранение на душу населения, \$	53,5	2023
Расходы на здравоохранение, % ВВП	2,2	2023
ВВП на душу населения, \$	2 551	2023
ВВП на душу по ППС, \$	9 155	2023
Смертность от суицидов, на 100 тыс.	2,8	2021
Врачи (все специальности), на 1 000	0,72	2023
Медсестры и акушеры, на 1 000	0,7	2023
Ожидаемая продолжительность жизни, лет	74,7	2023
Население	171,5 млн	2023
Официальный курс, ед. нац. валюты за \$	106,31	2023

Таблица 5.47. Бангладеш: динамика 2019–2023 (Всемирный банк)

Год	Здравоохран., \$/чел.	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.
2019	45	2 130	3,1
2020	49	2 249	2,8
2021	56	2 483	2,8
2022	57	2 716	—
2023	53	2 551	—

Модельная оценка. Если Бангладеш направляет на психическое здоровье медианную по миру долю — 2% расходов на здравоохранение (WHO Mental Health Atlas 2024), это **\$1,1 на человека в год ≈ 114 ед. нац. валюты**. Реальная доля может отличаться: в странах с высоким доходом она достигает 5% и выше, в странах с низким доходом — ниже 1%.

Смертность от суицидов — **2,8 на 100 тыс.** (2021): ниже среднемировой (9,4) в 3.4 раза. Значение в умеренном диапазоне; при его трактовке важна полнота регистрации причин смерти. При расходах на здравоохранение менее \$200 на человека говорить о полноценной специализированной сети не приходится: реалистичная стратегия таких систем — интеграция базовой психиатрической помощи в первичное звено

(подход ВОЗ mhGAP), где один обученный врач общей практики заменяет недоступного специалиста.

Кадровый фон системы здравоохранения: 0,72 врача на 1 000 жителей и 0,7 медсестёр на 1 000. Психиатрические кадры почти всегда составляют лишь доли процента общего фонда, но именно общий фонд определяет, насколько реально встроить психиатрию в первичное звено. По паритету покупательной способности ВВП на душу — \$9 155: в 3,6 раза выше номинального, то есть внутренние цены ниже долларовых, и реальные возможности системы выше, чем кажется по номиналу. Ожидаемая продолжительность жизни — 74,7 года: интегральный фон, на котором работает вся система помощи, включая психиатрическую.

5.24. За пределами выборки: Уганда и Танзания

Две восточноафриканские страны не вошли в основную выборку Всемирного банка по техническим причинам полноты рядов, но присутствуют в докладе через пятистранное исследование стоимости тяжёлых психических расстройств (2022) — и заслуживают отдельного упоминания, потому что задают нижний край мировой вилки цены заботы.

Год обслуживания одного пациента с тяжёлым психическим расстройством обходится в Уганде в €1 288, а в Танзании — в €311: это полный годовой контур помощи, доступный системе. Для сравнения: в Германии — €10 493. Танзанийские €311 — это примерно €0,85 в день на человека, чья жизнь зависит от этой помощи; российский койко-день за 1 600 ₽ покрывает почти неделю танзанийского годового бюджета на пациента.

Именно для таких систем ВОЗ разработала стратегию mhGAP: когда специалистов нет и не будет в обозримом будущем, единственный способ закрыть разрыв в лечении — обучить базовым протоколам врачей общей практики и медсестёр. Вывод для российского читателя прямой: даже самая бедная система может делать осмысленные вещи, если тратит свои €311 на правильный уровень помощи.

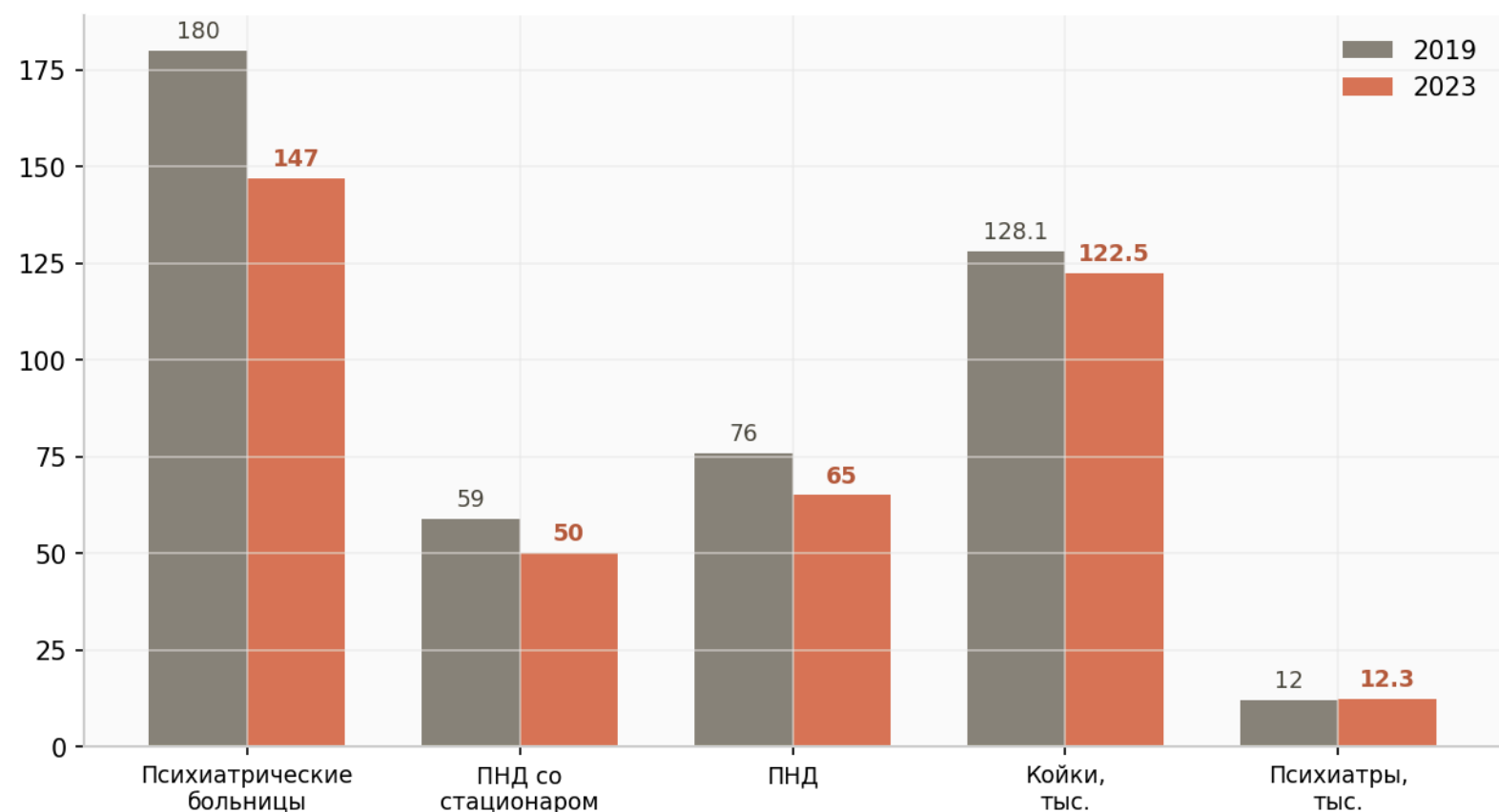
Россия: федеральная картина

6.1. Система в цифрах: 147 больниц и 122,5 тысячи коек

Российская психиатрическая служба в 2023 году — это **147 психиатрических больниц** (пять лет назад, в 2019-м, — 180), **50 психоневрологических диспансеров со стационаром** (в 2019-м — 59), **65 ПНД** (76), 1 897 организаций с психиатрическими подразделениями и **122 537 коек** (в 2019-м — 128 096). Обеспеченность — около **8,4 коек на 10 тыс. жителей** (0,84 на 1 000) — выше медианы ОЭСР (0,64), но далеко от японского максимума (2,58).

Кадровый костяк — **12 297 психиатров** (8,4 на 100 тыс. жителей): это уровень медианы стран с высоким доходом (8,6), хотя по ВВП на душу Россия — страна с доходом выше среднего. Система «переоснащена» кадрами и койками относительно своего богатства — наследие советской сети, которая строилась по нормативам обеспеченности, а не по бюджетным ограничениям.

Россия: мощности психиатрической службы, 2019 vs 2023



Источник: Сибирский вестник психиатрии и наркологии, 2024;4(125):82-96

Рисунок 6.1. Россия: мощности психиатрической службы, 2019 и 2023 годы (Сибирский вестник психиатрии и наркологии, 2024;4(125):82-96)

За четыре года сеть сжалась на 33 больницы (–18%) и 5,6 тыс. коек (–4,3%) — при почти неизменном числе психиатров. Сокращение идёт именно через закрытие мелких и обособленных стационаров: больницы укрупняются, койки концентрируются. Одновременно растёт новая инфраструктура: **18 клиник первого психотического эпизода** и 33 лечебно-трудовые мастерские — зачатки современной ранней помощи и реабилитации внутри старой стационарной системы.

Показатель, которым российская статистика отличается от мировой, — доля недобровольных госпитализаций: **5,3% в 2023 году** (6,1% в 2019-м; ~50% мировой медианы WHO Atlas 2024. Десятикратная разница объясняется не гуманностью, а методикой: в России недобровольной считается

6.2. Деньги: сколько стоит психиатрия для бюджета

Бюджетная рамка здравоохранения России: **4 964 млрд ₽ в 2020 году** (4,6% ВВП; 48% — средства ОМС, 27% — федеральный бюджет, 25% — бюджеты регионов), **5 167 млрд ₽ в 2021-м**. Взносы ОМС — 5,1% фонда оплаты труда. По данным Всемирного банка, в 2023 году текущие расходы на здравоохранение составили **7,0% ВВП, или \$1 003 на человека** (по среднегодовому курсу 85,25 ₽/\$ — около **85 500 ₽**).

Отдельной строки «психиатрия» в российской бюджетной росписи нет — как нет её и в большинстве стран. Применим мировую медиану ВОЗ (2% расходов на здравоохранение) как ориентир:

Модельная оценка. 2% от \$1 003 — это **≈\$20 на человека в год, или ≈1 700 ₽**. Для сравнения: верхняя граница стран с высоким доходом — \$65. Если российская психиатрия финансируется на медианном мировом уровне, её годовой «бюджет на человека» — цена одного посещения поликлиники средней руки. Каждые 0,5 п.п. сверх медианы — плюс **≈430 ₽ на человека в год, или ≈63 млрд ₽ на всю страну**.

Прямых опубликованных данных о совокупных расходах России на психиатрическую помощь (ОМС + бюджеты + соцзащита) в открытом доступе нет — само по себе показательное отличие от Великобритании, где эта цифра публикуется ежегодно как KPI. Для семинара это рабочая идея: запросить и свести такую цифру на уровне региона под силам каждому участнику — и это уже меняет бюджетный разговор.

6.3. Цена койко-дня: прейскуранты

Наиболее «осязаемая» цена заботы — сутки пребывания. Публичные прейскуранты платных услуг российских учреждений (2024–2026) дают такую вилку:

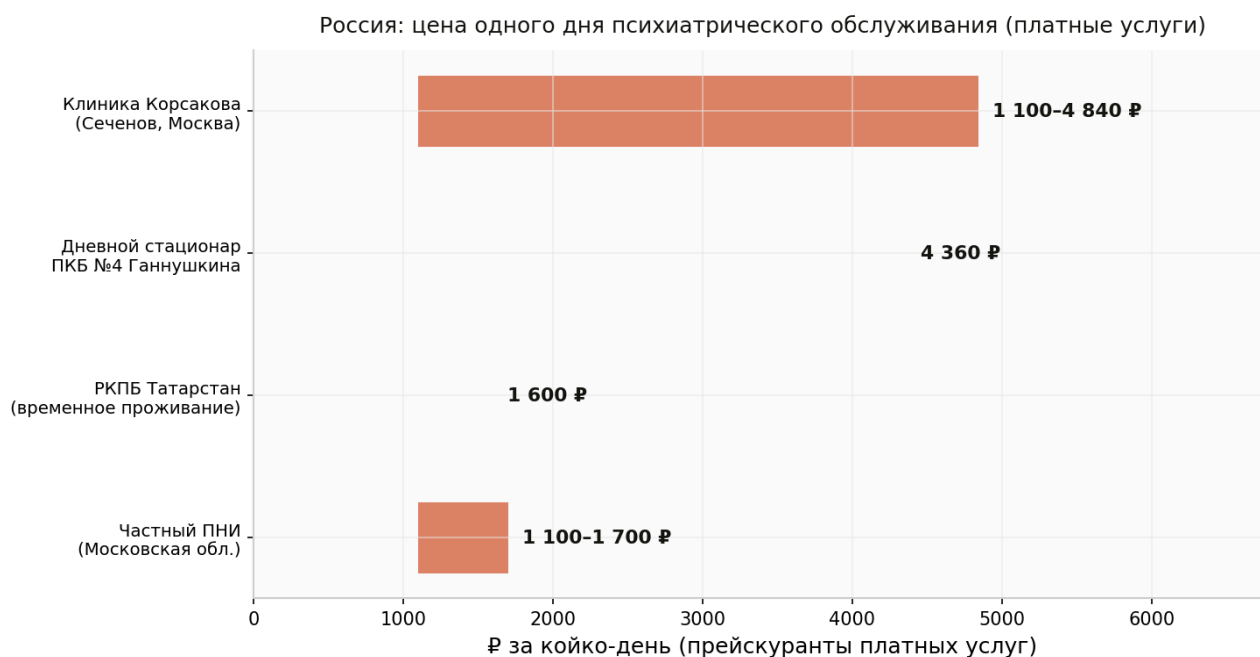


Рисунок 6.2. Цена одного дня психиатрического обслуживания по прейскурантам платных услуг, ₽

Таблица 6.1. Цена койко-дня в российских учреждениях (платные услуги, публичные прейскуранты)

Учреждение	Услуга	Цена, ₽/день	≈ \$ при 85 ₽/\$
Клиника им. Корсакова (Сеченовский университет, Москва)	койко-день	1 100 – 4 840	13 – 57
ПКБ №4 им. Ганнушкина (Москва)	дневной стационар	4 360	51
ПКБ №4 им. Ганнушкина (Москва)	сестринский уход	2 150 – 4 220	25 – 50
РКПБ (Татарстан)	временное проживание	1 600	19
Частные ПНИ (Московская область)	проживание с уходом	1 100 – 1 700	13 – 20

В пересчёте на месяц: от **33 000–51 000 ₽** в частном ПНИ Подмосковья до ~130 000 ₽ за дневной стационар московской федеральной клиники. Для сопоставления с миром: день психиатрического стационара в странах Западной Европы по внутренним тарифам страховщиков оценивается в сотни евро — российские цены ниже в 5–10 раз даже без учёта ППС. Это не «эффективность», а следствие низкой стоимости труда: зарплата — главный компонент цены койко-дня в любой стране.

Точка для дискуссии. При среднегодовом курсе 2026 года (~79,5 ₽/\$) российский койко-день за 1 600 ₽ стоит ~\$20. Год такого пребывания — ~\$7 300: это уже сопоставимо со стоимостью года пациента с тяжёлым расстройством в Израиле (€6 955). Иными словами, цена вопроса в России и в мире различается не на порядки — различается то, что человек получает за эти деньги.

6.4. Суицид: двадцать лет спадания

Смертность от суицидов в России снижается всё XXI столетие: с **21,8 на 100 тыс. в 2011 году до 9,1 в 2023-м и ≈8,3 в 2024-м** (данные Росстата). Это одно из самых быстрых устойчивых снижений в мире — за 13 лет показатель упал в 2,6 раза.

Россия: смертность от суицидов, 2011–2024, на 100 тыс. населения

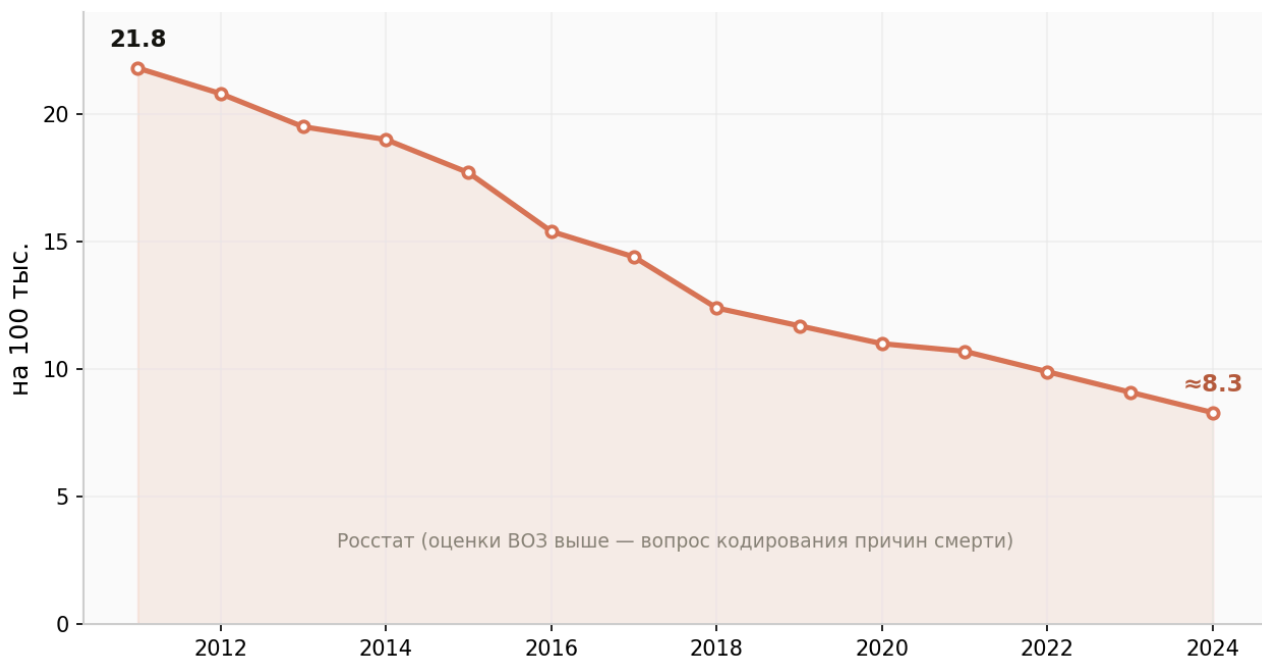


Рисунок 6.3. Россия: смертность от суицидов, 2011–2024 (Росстат)

Оговорка о методиках обязательна: оценки ВОЗ для России выше (в базе Всемирного банка за 2021 год — 21,4 на 100 тыс.), поскольку ВОЗ пересчитывает смертность от «неясных причин» и несчастных случаев с недостоверной классификацией. Разница между 9–11 (Росстат) и 21 (ВОЗ) — это не «фальсификация» и не «ошибка», а два разных ответа на вопрос, что считать суицидом; обе серии при этом показывают одинаковый тренд вниз. Мужская смертность примерно в **5,6 раза** выше женской; сельские мужчины — группа максимального риска (32,5 на 100 тыс.).

Региональная география экстремальна: от **3,8 в Москве** до **48 и выше** на 100 тыс. в Республике Алтай, Тыве, Бурятии, Ненецком и Чукотском АО — 12-кратный разброс внутри одной страны, сопоставимый с разбросом между странами мира.

Исследователи связывают его и с доходами, и с доступностью помощи, и с качеством выявления депрессии на первичном звене: где депрессию находят раньше, суицидов меньше.

6.5. Ранняя помощь и общинные формы: что уже есть в России

Внутри стационароцентричной системы последних лет выросли два заметных ростка новой модели. Первый — **18 клиник первого психотического эпизода**: специализированные подразделения, работающие с пациентами в первые годы болезни, когда исход наиболее обратим. Международный консенсус (программы раннего вмешательства типа EPPIC/TIPS) состоит в том, что сокращение длительности нелеченого психоза — самый дешёвый способ улучшить долгосрочный прогноз; российская сеть клиник первого эпизода — прямое внедрение этого принципа.

Второй росток — **33 лечебно-трудовые мастерские**: реабилитационные подразделения, где пациенты осваивают рабочие навыки в охраняемых условиях. По меркам развитых систем это зачаток того, что называется supported employment — сопровождаемая занятость, самый доказанный реабилитационный инструмент в психиатрии. Израильская реабилитационная корзина (часть IV) показывает, во что такие мастерские могут вырасти при отдельном финансировании и статусе права.

По критериям ВОЗ интеграции психиатрии в первичное звено (обучение врачей общей практики, доступность базовых психотропных препаратов, протоколы направления, надзор, информационные системы) 71% стран мира выполняют минимум три из пяти. Россия с её развитой диспансерной сетью имеет инфраструктурное преимущество для полного выполнения всех пяти — и это тот случай, когда догонять не нужно, нужно довести до конца уже начатое.

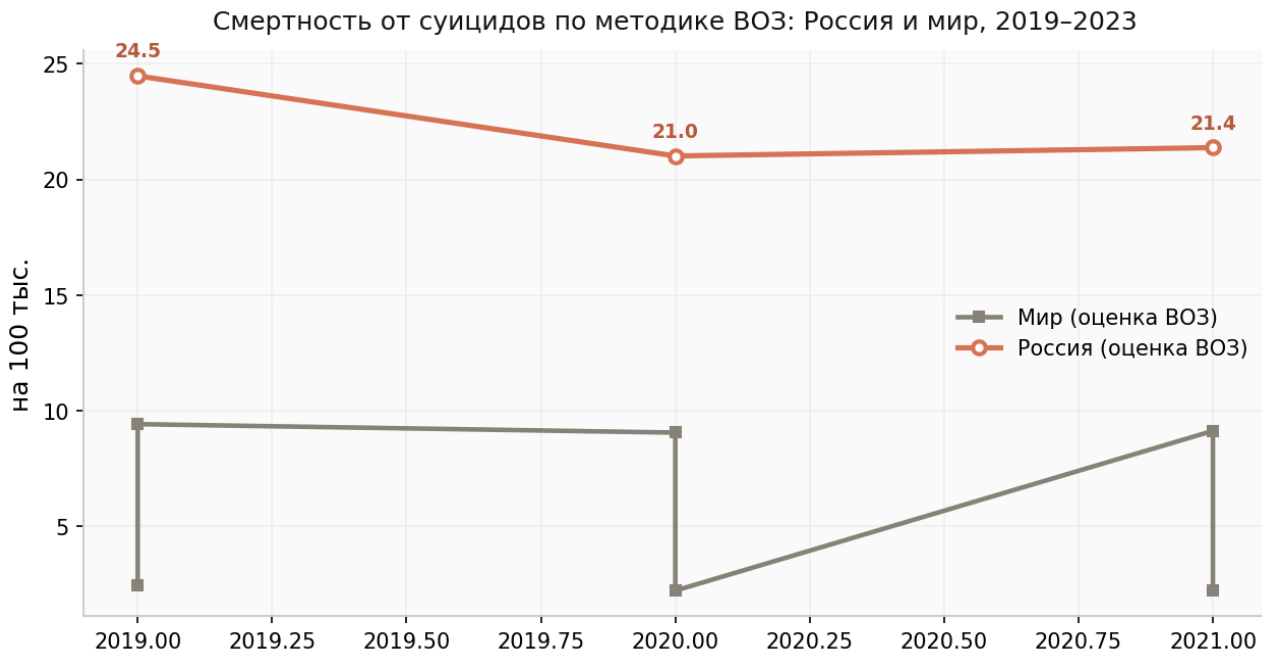


Рисунок 6.4. Смертность от суицидов по методике ВОЗ: Россия и мир, 2019–2023 (Всемирный банк)

Оценка ВОЗ подтверждает тренд Росстата: и по международной методике российская смертность снижается — но остаётся примерно вдвое выше среднемировой. Разрыв «вдвое» — это и есть размер задачи для системы ранней помощи.

6.6. Россия на мировой карте: позиции в выборке 48 стран

Таблица 6.2. Позиция России по ключевым показателям среди 48 стран (Всемирный банк)

Показатель	Значение РФ	Место	Направление «лучше»
Расходы на здравоохранение, \$/чел.	1 003	28 из 48	выше — лучше
Расходы на здравоохранение, % ВВП	7,0	31 из 44	выше — лучше
Суициды, на 100 тыс.	21,4	3 из 48	ниже — лучше
Врачи, на 1 000	5,11	4 из 48	выше — лучше
ОПЖ, лет	73,3	40 из 48	выше — лучше
ВВП/чел., \$	13 987	27 из 48	выше — лучше

Профиль позиций симметричен: по кадрам и коечной обеспеченности Россия держится в верхней половине таблицы, по расходам и продолжительности жизни — в средней, по суицидальной смертности (по методике ВОЗ) — в зоне повышенного риска. Иными словами, у России есть ресурсный задел, который не конвертируется в исходы автоматически: между «иметь психиатров» и «снизить риски» стоит организация помощи — ранняя, амбулаторная, общинная.

ЧАСТЬ VII

Регионы России: география цены заботы

Российская психиатрия и соцобслуживание финансируются преимущественно из региональных бюджетов и территориальных фондов ОМС — поэтому «средней российской цены» не существует: есть 89 региональных рынков заботы с разными ценами, нормативами и традициями. В этой части — то, что можно сказать о регионах, опираясь только на проверяемые данные.

7.1. Москва: реформа коечного фонда как национальный прецедент

Московский кейс — самый документированный пример сжатия психиатрической стационарной базы в России. Обеспеченность психиатрическими койками в городе снижалась со **118,1 на 100 тыс. жителей (2013)** до **62 на 100 тыс. (2016)**, а планы оптимизации предусматривали дальнейшее сокращение — до порядка 12,5 на 100 тыс. при рекомендуемом ориентире ~140 на 100 тыс. для полного контура потребности (оценки Г.Е. Улумбековой по материалам столичной реформы). Важно, что ВОЗ различает койки острые, реабилитационные и длительного ухода — и реформа ударила прежде всего по последним, фактически перенося их функцию в психоневрологические интернаты.

Московский опыт задал всероссийскую рамку дискуссии: высвобождаемые стационарные ресурсы должны превращаться в дневные стационары, кризисные службы и сопровождаемое проживание — но на практике темпы сокращения коек и темпы роста общинных альтернатив редко совпадают. Цена дня в московских учреждениях (таблица 6.1) — верхняя граница российской вилки: 4 360 ₽ за пациенто-день дневного стационара ПКБ №4 им. Ганнушкина.

7.2. Татарстан: цена проживания вне Москвы

Республиканская клиническая психиатрическая больница Татарстана публикует цену временного проживания — **1 600 ₽ в сутки** (~\$19 по курсу 2023 года). Это нижняя середина российской вилки и показательный ориентир для регионов: в полтора-два раза дешевле московских федеральных тарифов при той же базовой структуре услуги (койка, питание, наблюдение).

Разница «Москва — регион» в 1,5–2,5 раза по цене дня заботы воспроизводит общую российскую пропорцию доходов и зарплат. Для межрегиональных сравнений внутри страны корректнее всего считать не в рублях, а в «днях средней региональной

зарплаты»: койко-день за 1 600 Р при среднероссийской начисленной зарплате — это около 2,2% месячного заработка; тот же день в расчёте на московскую зарплату — около 1,5%.

7.3. Региональные различия смертности: двенадцатикратная Россия

Данные Росстата по суицидальной смертности дают самый резкий разрез регионального неравенства, доступный в открытой статистике. Минимум — **3,8 на 100 тыс. в Москве**; максимум — **48+ на 100 тыс.** в Республике Алтай, Тыве, Бурятии, Ненецком и Чукотском автономных округах. Сельские мужчины — 32,5 на 100 тыс. как усреднение по стране.

Таблица 7.1. Региональные ориентиры суицидальной смертности (Росстат, последние опубликованные годы)

Группа регионов / показатель	На 100 тыс. жителей
Москва (минимум)	3,8
Россия в целом (2023)	9,1
Сельские мужчины (по стране)	32,5
Республика Алтай, Тыва, Бурятия, Ненецкий АО, Чукотский АО (максимум)	48 и выше

Исследовательский консенсус: региональные различия суицидальной смертности в России коррелируют с качеством выявления депрессии на первичном звене сильнее, чем с числом психиатрических коек. Это тот же вывод, который ВОЗ делает для мира в целом: ранняя амбулаторная помощь дешевле и эффективнее поздней стационарной — и это прямое руководство к действию для региональных программ соцобслуживания.

7.4. ПНИ и социальное обслуживание: где встречаются две системы

Стиковка медицинской и социальной систем — главная тема семинара, и региональные данные показывают её цену. Психоневрологические интернаты (ПНИ) принимают людей, для которых психиатрическая больница уже не нужна, а самостоятельная жизнь ещё невозможна. Рынок частных ПНИ Подмосковья оценивает эту услугу в **1 100–1 700 Р в сутки (33 000–51 000 Р в месяц)** — при средней пенсии по инвалидности это соотношение на грани доступности, и именно оно определяет спрос на государственные места.

Бразильский опыт (часть V) предлагает работающую альтернативу: реабилитационное пособие «Возвращение домой» (~\$140 в месяц) позволяет

выпускать людей из интернатов в сопровождаемое проживание, что обходится системе дешевле койко-места. Российская практика сопровождаемого проживания развивается пока пилотами; её масштабирование — самый короткий путь к снижению и расходов, и институционализации одновременно.

Практический вывод части. Внутри одной страны цена дня заботы различается в 2–3 раза, а рискованные исходы — в 12 раз. Значит, дело не только в деньгах: организация помощи (раннее выявление, дневные формы, сопровождаемое проживание) даёт региону больше, чем пропорциональное увеличение бюджета.

7.5. Девять чисел, которые стоит знать о своём регионе

Завершаем часть практическим инструментом. Международный опыт доклада сводится к девяти показателям, которые любой регион России может собрать из собственной отчётности за один рабочий день — и сразу увидеть свою систему глазами мирового сравнения:

1. Койки психиатрические на 100 тыс. жителей — ориентиры: медиана ОЭСР 64, Россия 84, Москва после реформы 62.
2. Психиатры на 100 тыс. — ориентиры: мировая медиана высокодоходных стран 8,6; Россия 8,4.
3. Доля госпитализаций длиннее года — мировой маркер проблемы: более 20%.
4. Доля повторных госпитализаций за год — антирекорд выборки: 46,7% (Казахстан).
5. Средняя длительность пребывания, дни — ориентиры: Казахстан 51,4; Япония 266; западноевропейская норма — недели.
6. Цена койко-дня, Р — российская вилка: 1 100–4 840.
7. Суицидальная смертность на 100 тыс. — российская вилка: 3,8 (Москва) — 48+ (Алтай, Тыва, Бурятия, Ненецкий и Чукотский АО).
8. Доля расходов на психическое здоровье в бюджете здравоохранения региона — мировая медиана 2%; британский KPI 8,4–9,0%.
9. Число мест сопровождаемого проживания на 100 тыс. — показатель, по которому Россия пока не имеет общей статистики, и его появление в отчётности — уже шаг вперёд.

Регион, который заполнил эту девятку, получает автоматически: позицию в мировых рейтингах доклада, аргументы для бюджетного процесса (части I и VIII) и повестку для реформы (стратегии из раздела 8.6).

Цена и качество: итоговое сравнение

8.1. Сводные таблицы 48 стран

Всё, что доклад рассказывал по частям, сводится в две таблицы. Первая — фактическая: расходы на здравоохранение, богатство, суицидальная смертность, кадры и продолжительность жизни для всех 48 стран выборки. Вторая — модельная: сколько составили бы расходы на психическое здоровье при мировой медиане ВОЗ в 2% бюджета здравоохранения, в долларах и национальных валютах.

Таблица 8.1. Сводная таблица 48 стран: расходы, богатство, суицидальная смертность, кадры, продолжительность жизни (Всемирный банк, последние доступные годы; Россия выделена)

#	Страна	Здравоохран., \$/чел.	% ВВП	ВВП/чел., \$	Суициды/100 тыс.	Врачи/1 000	ОПЖ, лет
1	США	13 473	16.7	82 587	15.6	3.68	78.4
2	Норвегия	8 296	9.4	90 984	13.2	4.97	83.0
3	Исландия	7 065	8.7	82 201	11.9	4.37	82.5
4	Австралия	6 980	10.4	65 058	13.1	4.09	83.1
5	Ирландия	6 878	6.6	106 819	8.6	3.88	82.8
6	Дания	6 511	9.6	68 044	10.5	4.50	81.8
7	Германия	6 395	11.7	54 777	12.9	4.53	81.0
8	Нидерланды	6 372	9.8	63 516	11.5	3.88	81.9
9	Австрия	6 268	11.2	56 580	14.5	5.51	81.8
10	Швеция	6 206	11.2	54 950	13.8	4.41	83.3
11	Канада	6 187	11.2	54 848	9.4	2.82	81.6
12	Бельгия	5 931	10.8	55 245	18.4	3.57	82.4
13	Финляндия	5 515	10.5	52 865	14.6	3.61	81.6
14	Великобритания	5 407	11.0	49 920	9.6	3.30	81.2
15	Франция	5 149	11.5	44 700	16.6	3.28	82.8
16	Новая Зеландия	4 997	10.1	49 302	11.9	3.61	81.8
17	Израиль	3 928	7.1	52 126	4.4	3.80	83.2
18	Япония	3 638	10.7	35 215	17.4	2.65	84.0
19	Италия	3 283	8.4	39 280	7.0	4.19	83.4
20	Испания	3 107	9.2	33 493	8.7	4.29	83.9
21	Республика Корея	3 044	8.6	35 674	27.5	2.61	83.4
22	Чехия	2 671	8.4	31 762	13.3	4.35	79.8
23	Греция	1 963	8.4	23 344	4.7	6.58	81.7
24	Чили	1 737	10.2	17 082	7.7	3.33	81.2
25	Польша	1 578	7.1	22 145	13.7	4.03	78.3
26	Аргентина	1 457	10.3	14 262	7.9	5.11	77.4
27	Бразилия	1 010	135	3	7.6	2.36	75.8
28	Россия	1 003	135	3	21.4	5.11	73.3

29	Армения	767	9.3	8 159	2.5	3.36	77.5
30	Китай	763	5.9	12 951	8.9	3.11	78.0
31	Мексика	761	5.5	13 831	7.0	2.59	75.1
32	Колумбия	571	8.2	7 012	5.0	2.54	77.7
33	Беларусь	558	7.1	7 897	15.6	4.72	74.2
34	Грузия	554	6.9	8 284	5.1	5.64	74.5
35	Турция	548	н/д	13 375	2.7	2.24	77.2
36	ЮАР	537	н/д	6 034	22.3	0.79	66.1
37	Казахстан	490	3.8	12 879	14.6	3.75	74.4
38	Украина	370	8.2	5 140	21.2	3.53	73.4
39	Таиланд	327	н/д	7 211	16.6	0.54	76.4
40	Вьетнам	197	н/д	4 323	7.3	1.11	74.6
41	Египет	141	4.9	3 457	0.6	0.67	71.6
42	Индонезия	132	2.7	4 876	1.2	0.52	71.1
43	Кения	85	4.4	1 943	4.6	0.29	63.6
44	Индия	85	3.3	2 434	12.6	0.72	72.0
45	Нигерия	67	4.2	2 139	5.0	0.38	54.5
46	Бангладеш	53	2.2	2 551	2.8	0.72	74.7
47	Эфиопия	35	2.8	1 056	6.1	0.14	67.3
48	Пакистан	30	2.5	1 360	5.6	1.16	67.6

Таблица 8.2. Модельная оценка расходов на психическое здоровье при мировой медиане 2% бюджета здравоохранения: на человека в год, в долларах и национальной валюте (курс Всемирного банка PA.NUS.FCRF)

#	Страна	2% от расходов, \$/чел.	В нац. валюте
1	США	\$269.5	\$269.5
2	Норвегия	\$165.9	1 753
3	Исландия	\$141.3	19 490
4	Австралия	\$139.6	210
5	Ирландия	\$137.6	127
6	Дания	\$130.2	897
7	Германия	\$127.9	118
8	Нидерланды	\$127.4	118
9	Австрия	\$125.4	116
10	Швеция	\$124.1	1 317
11	Канада	\$123.7	167

12	Бельгия	\$118.6	110
13	Финляндия	\$110.3	102
14	Великобритания	\$108.1	87
15	Франция	\$103.0	95
16	Новая Зеландия	\$99.9	163
17	Израиль	\$78.6	288
18	Япония	\$72.8	10 223
19	Италия	\$65.7	61
20	Испания	\$62.1	\$62.1
21	Республика Корея	\$60.9	79 485
22	Чехия	\$53.4	1 186
23	Греция	\$39.3	36
24	Чили	\$34.7	29 176
25	Польша	\$31.6	133
26	Аргентина	\$29.1	8 633
27	Бразилия	\$20.2	101
28	Россия	\$20.1	1 709
29	Армения	\$15.3	6 020
30	Китай	\$15.3	108
31	Мексика	\$15.2	270
32	Колумбия	\$11.4	49 416
33	Беларусь	\$11.2	34
34	Грузия	\$11.1	29
35	Турция	\$11.0	\$11.0
36	ЮАР	\$10.7	\$10.7
37	Казахстан	\$9.8	4 468
38	Украина	\$7.4	271
39	Таиланд	\$6.5	\$6.5
40	Вьетнам	\$3.9	\$3.9
41	Египет	\$2.8	87
42	Индонезия	\$2.6	40 158
43	Кения	\$1.7	238
44	Индия	\$1.7	140
45	Нигерия	\$1.3	862

46	Бангладеш	\$1.1	114
47	Эфиопия	\$0.7	38
48	Пакистан	\$0.6	171

8.2. Сколько стоит год жизни с тяжёлым расстройством: пять стран

Единственное прямое межстрановое измерение полной стоимости обслуживания одного пациента с тяжёлым психическим расстройством (шизофрения и родственные расстройства) — исследование 2022 года, охватившее пять стран с принципиально разным уровнем дохода:

Таблица 8.3. Годовая стоимость обслуживания одного пациента с тяжёлым психическим расстройством (пятистранное исследование, 2022)

Страна	€ в год	≈ \$ в год*	Что входит в счёт
Германия	10 493	≈11 300	лечение, реабилитация, сопровождаемое жильё, пенсионное обеспечение
Израиль	6 955	≈7 500	лечение плюс легализованная реабилитационная корзина (жильё, занятость)
Уганда	1 288	≈1 390	преимущественно лечение и базовая поддержка
Индия	1 013	≈1 090	лечение; семья несёт основную нагрузку ухода
Танзания	311	≈335	минимальный лечебный контур

* Пересчёт по среднему курсу €/€ ≈1,08 (2023). Разброс 33 раза отражает и разные цены, и — в большей степени — разный фактический объём помощи.

Российскую точку на этой шкале можно прикинуть через цену койко-дня: год стационарного пребывания по тарифу 1 600 Р/день — 584 000 Р ≈ \$6 850 по курсу 2023 года, то есть между Израилем и Германией по цене. Но годовая стационаризация — крайний, вырожденный сценарий: реальный российский пациент живёт между стационаром, ПНД и семьёй, и его «годовой счёт» складывается из долей всех трёх.

8.3. Платить больше — значит ли жить лучше?

Наложение трёх осей доклада друг на друга даёт четыре устойчивых вывода.

Первый: деньги задают потолок, но не результат. Корея тратит \$3 044 на человека и имеет худшую суицидальную статистику развитого мира (27,5); Греция тратит \$1 963 — и держит 4,7 на 100 тыс. Между расходами и смертностью от суицидов нет простой пропорции: культура, алкоголь, социальные связи и ранняя доступность помощи работают поверх бюджета.

Второй: структура важнее суммы. США тратят больше всех и держат меньше коек, чем медиана ОЭСР; Япония при сопоставимых ресурсах — в 7 раз больше коек. Одни и те же деньги покупают принципиально разные системы — и разные судьбы пациентов.

Третий: общинная помощь — не экономия, а перенос. Бразилия, Италия и Великобритания показывают: деинституционализация не сокращает расходы, а перемещает их из больничного бюджета в бюджет общинных служб, жилья и пособий. Тот, кто обещает «закрыть больницы и сэкономить», не дочитал мировой опыт до конца.

Четвёртый: самая дорогая ошибка — поздняя помощь. Расчёт Chisholm (1:4), британская очередь в 1,8 млн человек, казахстанские 46,7% повторных госпитализаций — три разных проявления одного закона: система, которая ждёт обострения, платит максимальную цену.

8.4. Качество как контрольный список

По итогам сравнения можно предложить участникам семинара чек-лист из шести измеримых признаков зрелой системы помощи — все шесть встречались в докладе как проверяемые числа:

1. Доля бюджета здравоохранения на психическое здоровье — не ниже мировой медианы 2% и прозрачно публикуется.
2. Доля недобровольных госпитализаций посчитана по сопоставимой с ВОЗ методике — иначе сравнение бессмысленно.
3. Доля госпитализаций длиннее года стремится к нулю (мировой ориентир проблемы — более 20%).
4. Доля повторных госпитализаций снижается год к году (ориентир-антитезис: 46,7% в Казахстане).
5. Есть денежный инструмент деинституционализации — пособие на сопровождаемое проживание (бразильская модель).
6. Суицидальная смертность считается и публикуется по регионам — как главный интегральный индикатор.

8.5. Крайние точки выборки: рейтинги

Таблица 8.4. Пять стран с наивысшей смертностью от суицидов (2021, ВБ/ВОЗ)

#	Страна	на 100 тыс.
1	Республика Корея	27,5
2	ЮАР	22,3

3	Россия	21,4
4	Украина	21,2
5	Бельгия	18,4

Таблица 8.5. Пять стран с наименьшей зарегистрированной смертностью от суицидов (с оговоркой о полноте регистрации)

#	Страна	на 100 тыс.
1	Бангладеш	2,8
2	Турция	2,7
3	Армения	2,5
4	Индонезия	1,2
5	Египет	0,6

Таблица 8.6. Пять стран с наивысшей ожидаемой продолжительностью жизни

#	Страна	лет
1	Япония	84,0
2	Испания	83,9
3	Республика Корея	83,4
4	Италия	83,4
5	Швеция	83,3

Таблица 8.7. Пять стран с наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни

#	Страна	лет
1	Пакистан	67,6
2	Эфиопия	67,3
3	ЮАР	66,1
4	Кения	63,6
5	Нигерия	54,5

Крайние точки — не приговор, а диагноз системы: высокая суицидальная смертность при высоких расходах (Корея) и низкая при низких (Греция, Израиль) показывают, что исход определяется сочетанием ресурсов, организации и культурного контекста.

8.6. Три стратегии для трёх бюджетов

Опыт 48 стран сводится к трём устойчивым стратегиям — по одной на каждый ресурсный этаж:

Таблица 8.8. Стратегии развития помощи в зависимости от ресурсной базы

База (расходы на здравоохран.)	Стратегия	Примеры
До \$200/чел.	Интеграция в первичное звено (mhGAP): обучение врачей общей практики, базовые препараты, протоколы	Индия (DMHP в 767 округах), Эфиопия, Кения
\$200–3 000/чел.	Перебалансировка: сжатие длинных стационаров, дневные стационары, пособия на жизнь в общине	Бразилия (CAPS + Volta para Casa), Казахстан, Россия
От \$3 000/чел.	Паритет и очереди: KPI доли бюджета, кризисные службы, сокращение ожидания	Великобритания (Mental Health Investment Standard), Франция

ЧАСТЬ IX

Выводы для семинара и источники

9.1. Десять главных чисел доклада

1. **\$2,69** — мировая медиана государственных расходов на психическое здоровье на человека в год (WHO Atlas 2024).
2. **2%** — медианная доля бюджетов здравоохранения на психическое здоровье; не меняется с 2017 года (WHO Atlas 2024).
3. **\$0,04 против \$65** — разброс расходов на человека между беднейшими и богачейшими странами: 1 625 раз.
4. **\$2,5 трлн → \$6,0 трлн** — глобальная стоимость психических расстройств в 2010 году и прогноз на 2030-й (Bloom et al., 2011).
5. **1 : 4** — окупаемость инвестиций в лечение депрессии и тревоги (Chisholm et al., The Lancet Psychiatry, 2016).
6. **86 : 1** — разрыв в обеспеченности психиатрами между богатыми и бедными странами (ВОЗ, 2021).
7. **2,58 против 0,08** — психиатрические койки на 1 000 жителей в Японии и Италии: 32-кратный разброс внутри ОЭСР.
8. **122 537 коек, 12 297 психиатров** — мощность психиатрической службы России, 2023 год.
9. **21,8 → 8,3** — снижение смертности от суицидов в России с 2011 по 2024 год, на 100 тыс. (Росстат).
10. **1 600 Р** — цена суток временного проживания в РКПБ Татарстана; точка отсчёта российской цены заботы.

9.2. Что обсудить в секциях

Первый вопрос — про прозрачность. Великобритания публикует долю психического здоровья в бюджете NHS как KPI. Можем ли мы свести и опубликовать такую цифру хотя бы на уровне своего региона — и кто должен это сделать: Минздрав, Минтруд или сами учреждения?

Второй вопрос — про перенос денег вслед за человеком. Бразильское пособие «Возвращение домой» стоит дешевле койко-места. Какой механизм — пособие, сертификат, социальный заказ — способен выполнить эту функцию в российском соцобслуживании?

Третий вопрос — про повторные госпитализации. Казахстанские 46,7% — антирекорд, но и российская «вращающаяся дверь» никем не отменялась. Считает

ли ваше учреждение эту долю — и что она показывает?

Четвёртый вопрос — про цену дня. Если сутки заботы стоят 1 600–4 800 ₽, что именно покупает система за эти деньги — и что она могла бы купить вместо этого за ту же сумму в амбулаторном звене?

9.3. Квиз по материалам доклада

Для интерактивных сессий семинара: пятнадцать вопросов, построенных строго на числах доклада. Ответы — в конце раздела.

- Какова мировая медиана государственных расходов на психическое здоровье на человека в год (WHO Atlas 2024)?
а) \$2,69 · б) \$26,9 · в) \$269 · г) \$0,27
- Какая доля бюджетов здравоохранения в мире в медиане идёт на психическое здоровье?
а) 0,2% · б) 2% · в) 12% · г) 20%
- Во сколько раз различаются расходы на человека между странами с высоким и низким доходом (\$65 против \$0,04)?
а) в 16 раз · б) в 160 раз · в) в 1 625 раз · г) в 16 000 раз
- Какова оценка глобальной стоимости психических расстройств в 2030 году (Bloom et al.)?
а) \$1 трлн · б) \$2,5 трлн · в) \$6 трлн · г) \$16,3 трлн
- Какова окупаемость инвестиций в лечение депрессии и тревоги по Chisholm et al.?
а) 1:1 · б) 1:2 · в) 1:4 · г) 1:10
- В какой стране больше всего психиатрических коек на 1 000 жителей?
а) США · б) Германия · в) Япония · г) Россия
- Сколько психиатрических коек в России в 2023 году?
а) 25 988 · б) 51 393 · в) 122 537 · г) 147 000
- Какая страна закрыла государственные психиатрические больницы законом 1978 года?
а) Бразилия · б) Италия · в) Великобритания · г) Франция
- Как называется бразильское пособие для выписанных после длительных госпитализаций?
а) «Новый старт» · б) «Возвращение домой» · в) «Тихая гавань» · г) «Второй шанс»
- Какова доля недобровольных госпитализаций в России в 2023 году по национальной статистике?
а) 5,3% · б) 25% · в) 50% · г) 78%
- До скольких на 100 тыс. снизилась смертность от суицидов в России к 2024 году (Росстат)?
а) 21,8 · б) 15,6 · в) ≈8,3 · г) 3,8

12. Какой регион России имеет минимальную суицидальную смертность?
а) Татарстан · б) Москва · в) Санкт-Петербург · г) Краснодарский край
13. Какую долю бюджета Минздрава Индии составляют расходы на психическое здоровье (FY2025-26)?
а) 11,8% · б) 1,18% · в) 0,118% · г) 5%
14. Какова средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре Японии в 2018 году?
а) 26,6 дня · б) 51,4 дня · в) 266 дней · г) 500 дней
15. Сколько человек в Англии ждут психиатрической помощи NHS?
а) 180 тыс. · б) 1,8 млн · в) 18 млн · г) 8,1 млн

Ответы. 1-а · 2-б · 3-в · 4-в · 5-в · 6-в · 7-в · 8-б · 9-б · 10-а · 11-в · 12-б · 13-б · 14-в · 15-б.

9.4. Источники

1. WHO. Mental Health Atlas 2024. Geneva: World Health Organization, 2025 (публикация результатов — сентябрь 2025).
2. WHO. Mental Health Atlas 2020. Geneva: World Health Organization, 2021.
3. WHO. Mental Health Atlas 2014. Geneva: World Health Organization, 2015.
4. WHO. Mental Health Atlas 2011. Geneva: World Health Organization, 2011.
5. World Bank Open Data: индикаторы SH.XPD.CHEX.PC.CD, SH.XPD.CHEX.GD.ZS, NY.GDP.PCAP.CD, NY.GDP.PCAP.PP.CD, SH.STA.SUIC.P5, SH.MED.PHYS.ZS, SH.MED.NUMW.P3, SP.DYN.LE00.IN, SP.POPTOTL, PA.NUS.FCRF; выгрузка — август 2026.
6. WHO Global Health Observatory: кадры психического здоровья по группам дохода, 2021 (анализ опубликован: PMC12182244, 2025).
7. Bloom D.E. et al. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic Forum / Harvard School of Public Health, 2011.
8. Trautmann S., Rehm J., Wittchen H.-U. The economic costs of mental disorders. EMBO Reports, 2016;17(9):1245–1249.
9. Chisholm D. et al. Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry, 2016;3(5):415–424.
10. OECD. Health at a Glance / OECD Health Statistics: психиатрические и общие койки, 2022–2023; анализ вариации: Seita et al., PLOS, 2025.
11. SAMHSA. National Expenditures for Mental Health Services and Substance Abuse Treatment (SMA-14-4883), ряд 2009–2020.
12. NHS England: Mental Health Investment Standard, расходы 2022/23–2026/27; данные ICB 2025/26.
13. Assurance Maladie (Франция): расходы на santé mentale 2020, 2022, 2023 (ALD).
14. Минздрав Индии: бюджет психического здоровья FY2025-26 (ответ Раджъя Сабхи); DMHP; NIMHANS 2.0 (бюджет 2026-27).
15. Пятистранное исследование стоимости тяжёлых психических расстройств: Германия, Израиль, Уганда, Индия, Танзания, 2022.
16. Бразилия: Закон 10.216 (2001); коечный фонд 2002–2014; сеть CAPS; программа Volta para Casa.

17. Сибирский вестник психиатрии и наркологии, 2024;4(125):82–96 — состояние психиатрической службы РФ, 2019–2023.
18. Росстат: смертность от суицидов, 2011–2024; региональная разбивка.
19. Оценки ВОЗ смертности от суицидов (база Всемирного банка, 2021): Россия, Украина и др.
20. Улумбекова Г.Е. и др.: материалы по реформе психиатрической помощи Москвы (кочная обеспеченность 2013–2016, нормативы).
21. Прейскуранты платных услуг: клиника им. Корсакова (Сеченовский университет), ПКБ №4 им. Ганнушкина (Москва), РКПБ (Татарстан), частные ПНИ Московской области, 2024–2026.
22. Банк России: среднегодовые курсы Р/\$ 2023–2025, текущий курс 2026.
23. Национальные данные Казахстана: психиатрические койки, длительность пребывания, повторные госпитализации, 2019.
24. Консолидированный бюджет здравоохранения РФ 2020–2021 (структура ОМС / федеральный / региональный).

Доклад подготовлен для семинара «Пространство Новых Идей 2.0» (Минтруд России, Санкт-Петербург, 25–27 августа 2026 года). Перепечатка с указанием источника приветствуется. Все расчётные оценки помечены как модельные; ответственность за интерпретацию несут авторы доклада.

9.5. Как работать с докладом на семинаре

Три предложения по формату. **Первое — секционное:** части III–V построены так, что каждую страну можно разобрать за десять минут по одной схеме: паспорт → динамика → модельная оценка → вывод. Раздайте страны по секциям и сведите результаты в общую таблицу — получится живая копия таблиц части VIII, но собранная руками участников.

Второе — дискуссионное: четыре вопроса раздела 9.2 сформулированы так, чтобы у них не было правильного ответа без регионального контекста. Хороший приём — попросить каждого спикера начать с одного числа из девятки раздела 7.5 по своему региону.

Третье — игровое: квиз раздела 9.3 готов к загрузке в интерактивную платформу — пятнадцать вопросов покрывают все ключевые числа доклада и работают как проверка внимания зала после доклада.

9.6. Что почитать дальше

Если доклад нужно продолжить вглубь, три источника дадут максимум на вложенное время: **WHO Mental Health Atlas 2024** — единственное регулярное мировое сравнение систем; **Chisholm et al., The Lancet Psychiatry, 2016** — экономика окупаемости, на которой держатся все современные бюджетные аргументы; **Сибирский вестник психиатрии и наркологии, 2024;4(125)** — самый полный открытый разбор состояния российской службы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения: полный массив данных

Три таблицы воспроизводят весь рабочий массив доклада — по ним читатель может проверить любое число в тексте. Источник: Всемирный банк, Open Data, выгрузка августа 2026 года; страны отсортированы по расходам на здравоохранение на душу населения.

Таблица А.1. Приложение А. Экономика и расходы на здравоохранение (последние доступные годы)

#	Страна	ВВП/чел., \$	ВВП/чел. ППС, \$	Здравоохран., \$/чел.	% ВВП	Курс к \$
1	США	82 587	82 587	13 473	16,7	1,00
2	Норвегия	90 984	107 768	8 296	9,4	10,56
3	Исландия	82 201	82 257	7 065	8,7	137,94
4	Австралия	65 058	72 273	6 980	10,4	1,51
5	Ирландия	106 819	133 440	6 878	6,6	0,92
6	Дания	68 044	77 425	6 511	9,6	6,89
7	Германия	54 777	72 262	6 395	11,7	0,92
8	Нидерланды	63 516	80 392	6 372	9,8	0,92
9	Австрия	56 580	74 261	6 268	11,2	0,92
10	Швеция	54 950	68 458	6 206	11,2	10,61
11	Канада	54 848	64 962	6 187	11,2	1,35
12	Бельгия	55 245	72 630	5 931	10,8	0,92
13	Финляндия	52 865	63 467	5 515	10,5	0,92
14	Великобритания	49 920	60 787	5 407	11,0	0,80
15	Франция	44 700	60 927	5 149	11,5	0,92
16	Новая Зеландия	49 302	54 950	4 997	10,1	1,63
17	Израиль	52 126	55 301	3 928	7,1	3,67
18	Япония	35 215	52 726	3 638	10,7	140,49
19	Италия	39 280	60 350	3 283	8,4	0,92
20	Испания	33 493	55 661	3 107	9,2	н/д
21	Республика Корея	35 674	57 430	3 044	8,6	1 305,66
22	Чехия	31 762	56 062	2 671	8,4	22,20
23	Греция	23 344	42 614	1 963	8,4	0,92
24	Чили	17 082	33 174	1 737	10,2	840,07
25	Польша	22 145	48 473	1 578	7,1	4,20

26	Аргентина	14 262	30 246	1 457	10,3	296,26
27	Бразилия	10 378	21 193	1 010	9,7	4,99
28	Россия	13 987	44 299	1 003	7,0	85,16
29	Армения	8 159	21 552	767	9,3	392,48
30	Китай	12 951	25 200	763	5,9	7,08
31	Мексика	13 831	25 188	761	5,5	17,76
32	Колумбия	7 012	21 282	571	8,2	4 325,95
33	Беларусь	7 897	30 860	558	7,1	3,01
34	Грузия	8 284	25 093	554	6,9	2,63
35	Турция	13 375	н/д	548	н/д	н/д
36	ЮАР	6 034	н/д	537	н/д	н/д
37	Казахстан	12 879	38 547	490	3,8	456,17
38	Украина	5 140	17 680	370	8,2	36,57
39	Таиланд	7 211	н/д	327	н/д	н/д
40	Вьетнам	4 323	н/д	197	н/д	н/д
41	Египет	3 457	18 540	141	4,9	30,63
42	Индонезия	4 876	15 428	132	2,7	15 236,88
43	Кения	1 943	6 322	85	4,4	139,85
44	Индия	2 434	9 853	85	3,3	82,60
45	Нигерия	2 139	8 712	67	4,2	645,19
46	Бангладеш	2 551	9 155	53	2,2	106,31
47	Эфиопия	1 056	3 063	35	2,8	54,60
48	Пакистан	1 360	6 019	30	2,5	280,36

Таблица Б.1. Приложение Б. Здоровье, кадры, демография (последние доступные годы)

#	Страна	Суициды/100 тыс.	Врачи/1 000	Медсёстры/1 000	ОПЖ, лет	Население
1	США	15,6	3,68	н/д	78,4	336 755 052
2	Норвегия	13,2	4,97	16,5	83,0	5 519 601
3	Исландия	11,9	4,37	15,9	82,5	385 663
4	Австралия	13,1	4,09	13,4	83,1	26 659 922
5	Ирландия	8,6	3,88	14,8	82,8	5 311 538
6	Дания	10,5	4,50	12,2	81,8	5 946 952
7	Германия	12,9	4,53	12,2	81,0	83 287 273
8	Нидерланды	11,5	3,88	11,7	81,9	17 877 117
9	Австрия	14,5	5,51	11,3	81,8	9 131 761

10	Швеция	13,8	4,41	н/д	83,3	10 536 632
11	Канада	9,4	2,82	11,3	81,6	40 049 088
12	Бельгия	18,4	3,57	12,9	82,4	11 779 946
13	Финляндия	14,6	3,61	14,0	81,6	5 583 911
14	Великобритания	9,6	3,30	н/д	81,2	68 526 000
15	Франция	16,6	3,28	9,4	82,8	68 372 286
16	Новая Зеландия	11,9	3,61	12,3	81,8	5 200 000
17	Израиль	4,4	3,80	5,9	83,2	9 849 000
18	Япония	17,4	2,65	13,0	84,0	124 516 650
19	Италия	7,0	4,19	6,8	83,4	58 984 216
20	Испания	8,7	4,29	н/д	83,9	н/д
21	Республика Корея	27,5	2,61	9,1	83,4	51 712 619
22	Чехия	13,3	4,35	9,5	79,8	10 864 042
23	Греция	4,7	6,58	4,1	81,7	10 407 351
24	Чили	7,7	3,33	5,5	81,2	19 658 835
25	Польша	13,7	4,03	н/д	78,3	36 687 353
26	Аргентина	7,9	5,11	4,7	77,4	45 538 401
27	Бразилия	7,6	2,36	5,5	75,8	211 140 729
28	Россия	21,4	5,11	н/д	73,3	143 826 130
29	Армения	2,5	3,36	4,7	77,5	2 964 300
30	Китай	8,9	3,11	3,7	78,0	1 410 710 000
31	Мексика	7,0	2,59	3,0	75,1	129 739 759
32	Колумбия	5,0	2,54	1,5	77,7	52 321 152
33	Беларусь	15,6	4,72	10,8	74,2	9 178 298
34	Грузия	5,1	5,64	6,0	74,5	3 715 483
35	Турция	2,7	2,24	н/д	77,2	85 325 965
36	ЮАР	22,3	0,79	н/д	66,1	63 212 384
37	Казахстан	14,6	3,75	6,5	74,4	20 330 104
38	Украина	21,2	3,53	н/д	73,4	37 732 836
39	Таиланд	16,6	0,54	н/д	76,4	71 702 435
40	Вьетнам	7,3	1,11	н/д	74,6	100 352 192
41	Египет	0,6	0,67	н/д	71,6	114 535 772
42	Индонезия	1,2	0,52	3,2	71,1	281 190 067
43	Кения	4,6	0,29	2,3	63,6	55 339 003

44	Индия	12,6	0,72	1,7	72,0	1 438 069 596
45	Нигерия	5,0	0,38	1,6	54,5	227 882 945
46	Бангладеш	2,8	0,72	0,7	74,7	171 466 990
47	Эфиопия	6,1	0,14	1,2	67,3	128 691 692
48	Пакистан	5,6	1,16	0,5	67,6	247 504 495

Приложение В. Годы последних доступных данных

Прозрачность временной глубины: таблица показывает, за какой год стоит последнее значение каждого показателя в паспортах стран. Это важно при сравнении: суицидальная смертность почти везде за 2021 год, расходы — за 2023-й, кадры — за 2020–2022-й.

Таблица В.1. Год последнего доступного значения по странам и показателям (Всемирный банк)

#	Страна	Здравоохранение\$/чел.	Суициды	Врачи	ОПЖ	Курс	Население
1	США	2023	2021	2022	2023	2023	2023
2	Норвегия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
3	Исландия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
4	Австралия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
5	Ирландия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
6	Дания	2023	2021	2021	2023	2023	2023
7	Германия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
8	Нидерланды	2023	2021	2022	2023	2023	2023
9	Австрия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
10	Швеция	2023	2021	2021	2023	2023	2023
11	Канада	2023	2021	2023	2023	2023	2023
12	Бельгия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
13	Финляндия	2023	2021	2021	2023	2023	2023
14	Великобритания	2023	2021	2023	2023	2023	2023
15	Франция	2023	2021	2022	2023	2023	2023
16	Новая Зеландия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
17	Израиль	2023	2021	2023	2023	2023	2023
18	Япония	2023	2021	2022	2023	2023	2023
19	Италия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
20	Испания	2023	2021	2022	2023	—	—
21	Республика Корея	2023	2021	2022	2023	2023	2023

22	Чехия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
23	Греция	2023	2021	2022	2023	2023	2023
24	Чили	2023	2021	2023	2023	2023	2023
25	Польша	2023	2021	2023	2023	2023	2023
26	Аргентина	2023	2021	2023	2023	2023	2023
27	Бразилия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
28	Россия	2023	2021	2022	2023	2023	2023
29	Армения	2023	2021	2022	2023	2023	2023
30	Китай	2023	2021	2022	2023	2023	2023
31	Мексика	2023	2021	2022	2023	2023	2023
32	Колумбия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
33	Беларусь	2023	2021	2023	2023	2023	2023
34	Грузия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
35	Турция	2023	2021	2022	2023	—	2023
36	ЮАР	2023	2021	2022	2023	—	2023
37	Казахстан	2023	2021	2023	2023	2023	2023
38	Украина	2021	2021	2023	2023	2023	2023
39	Таиланд	2023	2021	2021	2023	—	2023
40	Вьетнам	2023	2021	2021	2023	—	2023
41	Египет	2023	2021	2020	2023	2023	2023
42	Индонезия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
43	Кения	2023	2021	2023	2023	2023	2023
44	Индия	2023	2021	2020	2023	2023	2023
45	Нигерия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
46	Бангладеш	2023	2021	2023	2023	2023	2023
47	Эфиопия	2023	2021	2023	2023	2023	2023
48	Пакистан	2023	2021	2021	2023	2023	2023